PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte II

Proponente: Município de Belo Horizonte
Processo SEI: 03101.000100/2026-33
Código do pleito: 7731025374/2026
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: BRL 626.880.000,00 **Valor da Contrapartida:** BRL 156.720.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 06
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 10
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 11
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 12
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 13
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 14
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 14
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 15
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 16
1. 5. Componentes 17
1. 5. 1. Informações do 1° componente 17
1. 5. 2. Informações do 2° componente 21
1. 5. 3. Informações do 3° componente 25
1. 5. 4. Informações do 4° componente 28
1. 6. Beneficiários 29
1. 7. Anexos 30
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 31
2. 1. Áreas estratégicas 31
2. 2. Anexos 33
3. GESTÃO 34
3. 1. Arranjo institucional 34
3. 1. 1. Descrição 34
3. 1. 2. Orgãos Executores 35
3. 1. 3. Estrutura Operacional 35
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 35
3. 2. Operacionalização e Manutenção 35
3. 3. Planejamento Estratégico 36
3. 4. Anexos 41
4. RISCOS 42
4. 1. Informações do 1° risco 42
4. 2. Informações do 2° risco 43
4. 3. Informações do 3° risco 44
4. 4. Informações do 4° risco 45
4. 5. Informações do 5° risco 46
4. 6. Informações do 6° risco 47
4. 7. Informações do 7° risco 48
4. 8. Anexos 49
5. FINANCIAMENTO 50
5. 1. Condições Financeiras da Operação 50
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 50

5. 2. Cronograma de Desembolso 52
5. 3. Contragarantias 53
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 53
6. ETAPAS REALIZADAS 54
6. 1. Etapas realizadas 54
6. 2. Anexos 54
7. Baixar todos os anexos 57
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte II

Sigla: Melhor Saúde BH II

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Município de Belo Horizonte

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, possui uma população estimada em mais de 2,3 milhões de habitantes, distribuída em território de elevada densidade demográfica marcada por significativa diversidade social, econômica e cultural.

O perfil etário de Belo Horizonte evidencia que a transição demográfica tem se intensificado, com redução das faixas etárias até 39 anos e aumento expressivo da população idosa, que já representa cerca de 20% dos habitantes, segundo estimativas do IBGE (2024). Esse processo é acompanhado pela transição epidemiológica, marcada pela predominância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), responsáveis por aproximadamente 30% das internações e 50% dos óbitos registrados em 2023. Essa mudança no perfil de adoecimento exige novas estratégias de atenção e de organização do cuidado, com ênfase na prevenção, na reabilitação e no acompanhamento contínuo das condições crônicas.

Em termos de renda, em julho de 2025 o município contava com 310.092 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, das quais 181.578 possuíam renda de até meio salário mínimo, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (2025). Ademais, Belo Horizonte é a terceira capital brasileira com o maior número de pessoas em situação de rua, segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.

Apesar da redução da taxa de desemprego para 9,5% em 2023, a expansão do trabalho informal e a diminuição da cobertura por planos privados de saúde mantêm elevada a demanda por atendimento na rede pública. Esse cenário reforça o papel estratégico do SUS-BH como principal garantidor do direito à saúde e como rede essencial para o cuidado das populações em situação de vulnerabilidade social.

Do ponto de vista econômico, entre 2022 e 2024, as despesas em saúde no município cresceram cerca de R$1,5 bilhão, alcançando R$6,3 bilhões em 2024, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esse aumento reflete a elevação dos custos assistenciais e operacionais, que vêm pressionando o orçamento municipal.

A análise da dependência do SUS por território demonstra acentuadas desigualdades socioeconômicas entre as regiões administrativas. As regionais Nordeste, Barreiro e Venda Nova apresentam maior proporção de usuários exclusivamente dependentes do sistema público, exigindo ampliação da capacidade instalada e fortalecimento da rede. Em contrapartida, a regional Centro-Sul concentra menor dependência, refletindo maior inserção no mercado formal e maior acesso a planos de saúde privados. Essa heterogeneidade reforça a necessidade de políticas e investimentos que considerem a equidade territorial e garantam a integralidade da atenção à saúde. Além disso, Belo Horizonte desempenha papel estratégico no Sistema Estadual de Saúde por sediar a Macrorregião de Saúde e abrigar unidades de referência em média e alta complexidade que atendem usuários de diversos municípios mineiros, o que amplia de forma expressiva a demanda sobre a rede municipal de saúde.

Apesar de um cenário de restrições financeiras, o Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH) mantém-se como uma rede estruturada, regionalizada e hierarquizada, integrando os três níveis de atenção – primária, secundária e terciária – e articulando ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, de forma a possibilitar a integralidade do cuidado.

A Atenção Primária à Saúde (APS), porta de entrada preferencial do sistema, apresenta cobertura expressiva e desempenha papel central na coordenação do cuidado e na organização das redes de atenção. Entre 2019 e 2024, observou-se crescimento contínuo da produção assistencial, com destaque para o aumento do número de atendimentos, que alcançou 7.962.645 em 2024, representando incremento de 2,7% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado, em especial, pela epidemia de dengue, que demandou intensa mobilização da rede assistencial. O número de visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde manteve-se elevado, ultrapassando sete milhões em 2024, o que evidencia o fortalecimento da vigilância em saúde no território e o papel estruturante da APS na garantia do cuidado longitudinal.

A Rede de Atenção Secundária é composta por unidades especializadas e centros de referência, como os Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs e CERSAMIs), os Centros de Reabilitação (CREABs) e os Centros de

Especialidades Odontológicas (CEOs), que asseguram o cuidado continuado e a integralidade das ações de saúde. Entre 2019 e 2024, observou-se crescimento progressivo nos atendimentos em saúde mental, totalizando 443.508 registros em 2024, dos quais 240.923 foram realizados na rede própria. Esse volume reflete o impacto de fatores sociais e econômicos, além dos efeitos pós-pandemia sobre a saúde mental da população. No mesmo período, verificou-se retomada gradual da produção assistencial nas áreas de atenção especializada e saúde bucal, após a redução observada durante a pandemia de COVID-19. Em 2024, foram registradas cerca de 1,6 milhão de consultas especializadas na rede contratada e 13,7 milhões de procedimentos ambulatoriais processados. Na saúde bucal, o número de tratamentos concluídos evoluiu de 25.082 em 2021 para 109.603 em 2024, enquanto os CEOs já contabilizam 39.061 atendimentos de janeiro a agosto de 2025. Os CREABs mantêm papel estratégico na oferta de serviços de reabilitação física, visual, auditiva e intelectual, além do tratamento de disfunções ortopédicas e neurológicas, com média de 20 mil atendimentos mensais, direcionados principalmente a pessoas com deficiência e dificuldades motoras.

Já a rede de urgência e emergência, composta pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), constitui componente essencial da atenção terciária e garante retaguarda às demandas agudas e de alta complexidade. O volume de atendimentos nas UPAs cresceu 46,5% entre 2020 e 2024, passando de 636.610 para 932.721 atendimentos, com maior concentração nas unidades Barreiro, Norte e Venda Nova, que atendem territórios com elevada dependência do SUS. Esse crescimento expressivo reflete tanto o aumento da demanda espontânea quanto a pressão gerada por eventos epidêmicos e pelo envelhecimento populacional.

No campo da Vigilância em Saúde, Belo Horizonte mantém ações permanentes de controle de zoonoses, de monitoramento de riscos sanitários e de promoção da saúde. Entre 2019 e 2024, foram realizadas mais de 170 mil cirurgias de esterilização animal, em consonância com a política municipal de controle ético da população de cães e gatos. Em 2024, o município enfrentou a maior epidemia de arboviroses de sua história, com 266.027 casos prováveis de dengue e 11.977 de chikungunya, o que demandou respostas rápidas, mobilização de equipes e reestruturação temporária de fluxos assistenciais. A gravidade e a magnitude desse evento reforçam a importância de investimentos contínuos em vigilância, infraestrutura e tecnologia para ampliar a capacidade de resposta a emergências em saúde pública.

Adicionalmente, informa-se que a cidade de Belo Horizonte vem avançando na utilização de ferramentas digitais e na integração tecnológica dos serviços de saúde, mas ainda enfrenta desafios relacionados à fragmentação de sistemas, limitações na interoperabilidade de dados e na cobertura de Telessaúde, especialmente em áreas periféricas. A gestão de informações e o monitoramento de doenças dependem de múltiplos sistemas isolados, o que pode dificultar a tomada de decisão em tempo real e a coordenação entre os diferentes níveis de atenção.

Inserido nesse contexto, o município de Belo Horizonte conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2017–2026) para o desenvolvimento de ações voltadas à superação e mitigação de vulnerabilidades estruturais e assistenciais da saúde. Embora as entregas e resultados do programa tenham sido fortemente impactados pela pandemia de Covid-19, observou-se avanço em indicadores estratégicos da assistência à saúde da população, como a Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que reduziu de 280,0 (linha de base em 2017) para 209,0 em 2024, e a Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica, que passou de 86,67% (2017) para 100% em 2024.

Apesar desses avanços, outros indicadores não apresentaram desempenho satisfatório e mantidos nesta proposição, como é o caso das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), que aumentaram de 16,60% para 25,97% em 2024, evidenciando a necessidade de fortalecimento das estruturas e dos serviços da atenção primária, alinhados às demandas do cuidado preventivo e do monitoramento contínuo de agravos crônicos.

Em síntese, o contexto de Belo Horizonte revela uma rede de saúde estruturada e abrangente, que desempenha papel regional de alta relevância, mas que enfrenta pressões crescentes decorrentes da expansão da demanda, do envelhecimento populacional, das emergências sanitárias recorrentes e do subfinanciamento crônico do sistema público de saúde. Esses fatores demandam ações estratégicas de modernização, requalificação da infraestrutura e fortalecimento da capacidade de gestão e de vigilância, de modo a assegurar a sustentabilidade e a efetividade das políticas públicas de saúde no município.

1. 2. 2. **Problema:**

O Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH), embora consolidado e reconhecido nacionalmente por sua abrangência e organização em rede, enfrenta desafios estruturais, tecnológicos e organizacionais que comprometem a eficiência operacional, a integração entre os níveis de atenção e a qualidade dos serviços ofertados à população. A expansão da demanda assistencial, o envelhecimento populacional, as emergências sanitárias recorrentes e o

subfinanciamento crônico intensificam as pressões sobre o sistema, revelando a necessidade de investimentos estruturantes que garantam a sustentabilidade da rede pública de saúde.

As deficiências na infraestrutura física das unidades de saúde, a insuficiência de equipamentos em serviços estratégicos e a fragmentação dos sistemas de informação limitam a capacidade de gestão integrada, dificultando o monitoramento de indicadores e o uso de dados como instrumento de apoio à decisão. Parte significativa das unidades de saúde apresenta estruturas obsoletas ou inadequadas, carecendo de intervenções de reconstrução, ampliação e modernização que assegurem condições adequadas de acessibilidade, conforto, segurança e eficiência na prestação dos serviços. Essa situação impacta diretamente a qualidade do cuidado, a produtividade das equipes e a satisfação dos usuários.

Na Atenção Primária à Saúde (APS) e na Rede de Saúde Mental, observa-se a necessidade de expansão e qualificação da estrutura assistencial, especialmente diante da crescente demanda por cuidado territorial, integral e contínuo. As limitações estruturais dos Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs e CERSAMIs) e dos Centros de Reabilitação (CREABs) comprometem a integralidade e a continuidade do cuidado, dificultando a articulação entre os níveis de atenção e a resposta oportuna às condições crônicas e aos transtornos mentais. O aumento de agravos relacionados à reabilitação física e funcional, decorrente, principalmente, de fatores como o envelhecimento populacional e o aumento de doenças crônicas e acidentes, reforça a urgência de adequação da capacidade instalada para atender às novas demandas epidemiológicas e sociais.

Na rede de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) constituem componente essencial para garantir o atendimento imediato a situações agudas e desafogar os serviços hospitalares. Contudo, a obsolescência parcial de sua infraestrutura e equipamentos compromete a resolutividade e a qualidade da atenção prestada. Essa fragilidade se acentua durante os períodos epidêmicos, quando há aumento expressivo do volume de atendimentos e sobrecarga das equipes, comprometendo o acolhimento e a assistência integral aos demais usuários do sistema.

A Vigilância em Saúde também enfrenta limitações estruturais e tecnológicas que dificultam a resposta efetiva às demandas epidemiológicas e ambientais. A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ/CCZ) necessita de modernização para ampliar sua capacidade de manejo de animais e fortalecer as ações de controle da raiva urbana, da leishmaniose visceral canina, da febre maculosa e da esporotricose zoonótica, atualmente restritas. As Centrais de Esterilização de Cães e Gatos funcionam com restrições físicas e logísticas que limitam a cobertura e a eficiência das ações de controle populacional e de prevenção de zoonoses. Essas deficiências reduzem a capacidade do município de responder de forma ágil e coordenada a doenças como raiva urbana, leishmaniose visceral canina, febre maculosa e esporotricose zoonótica, além de comprometer a biossegurança e o bem-estar animal.

No campo da gestão e da tecnologia da informação, persistem fragilidades na integração dos sistemas informatizados voltados à gestão de custos, contratos, produção e recursos humanos, o que dificulta a visão sistêmica das despesas e a alocação eficiente dos recursos públicos. A ausência de uma infraestrutura tecnológica padronizada para o teleatendimento e a limitação da rede de conectividade afetam a expansão de serviços como a Telessaúde, ferramenta essencial para a ampliação do acesso, o fortalecimento da resolutividade territorial e a redução de iniquidades no cuidado. Soma-se a isso a necessidade de modernização da gestão documental, uma vez que o município mantém um acervo físico volumoso e parcialmente inativo, composto por mais de 30 mil prontuários intermediários que demandam organização, digitalização e integração aos sistemas eletrônicos de informação em saúde. Essa situação compromete a confiabilidade, a rastreabilidade e a segurança das informações, dificultando o planejamento, o monitoramento e a tomada de decisão baseada em evidências.

O financiamento da saúde pública municipal revela fragilidades decorrentes do desequilíbrio na participação dos entes federados no custeio das ações e serviços de saúde. Historicamente, os recursos estaduais representam uma parcela reduzida das receitas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, o que contrasta com o papel estratégico desempenhado pela capital. Os repasses do governo estadual concentram-se, majoritariamente, em instituições hospitalares com funções assistenciais definidas pela política estadual, limitando a capacidade de investimento direto na rede própria do município e pressionando o orçamento local.

O subfinanciamento da saúde, marcado pela insuficiência e instabilidade dos repasses intergovernamentais, agrava as limitações estruturais e operacionais da rede. O desequilíbrio entre a demanda crescente por serviços do SUS-BH e o volume de recursos disponíveis impõe sobrecarga estrutural e financeira ao município, que precisa destinar parcela significativa de seu orçamento ao custeio de atendimentos que extrapolam sua base populacional, em razão do papel regional desempenhado pela rede. Essa condição compromete a execução de políticas públicas, a manutenção de equipes e a ampliação da capacidade instalada, impondo desafios constantes à sustentabilidade do sistema.

Essas restrições geram impactos diretos sobre o desempenho do SUS-BH. A fragmentação de informações e processos reduz a eficiência do planejamento e da execução de políticas, compromete o uso racional dos recursos,

limita a capacidade de resposta a emergências e dificulta a gestão baseada em resultados. Como consequência, a rede municipal enfrenta dificuldades para garantir a qualidade do cuidado, a equidade do acesso e a sustentabilidade financeira e operacional do sistema.

O cenário pós-pandemia de COVID-19 agravou essas fragilidades. A sobrecarga da rede durante o período pandêmico resultou em queda expressiva de consultas, cirurgias e procedimentos preventivos, o que impacta diretamente o controle de doenças crônicas e infecciosas e aumenta o risco de complicações futuras. Em Belo Horizonte, esse quadro se traduz em maior pressão sobre os serviços de média e alta complexidade, exigindo ampliação da capacidade ambulatorial e de reabilitação. Observou-se também queda significativa da cobertura vacinal: a imunização com a vacina pentavalente em menores de um ano, que em 2020 atingia 99,5%, caiu para 68,7% em 2021, 71,7% em 2022 e 66,7% em 2023, segundo dados oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte (2024). Essa redução impacta a imunidade coletiva e eleva o risco de reemergência de doenças erradicadas.

Em 2024, o Brasil vivenciou a maior epidemia de dengue da história, e Belo Horizonte registrou 266.027 casos prováveis da doença e 11.977 casos prováveis de chikungunya. Os casos confirmados e os óbitos por dengue em 2024 superaram amplamente os picos anteriores de 2016 e 2019, com aumento de 39,5% e 85,9% no número de casos confirmados e mais que o dobro de óbitos, respectivamente. Somente na Atenção Primária, foram atendidos 375.149 casos suspeitos de dengue, correspondendo a 6,5% do total de atendimentos realizados por médicos e enfermeiros em 2024. Nas UPAs, o número de atendimentos relacionados à dengue, entre fevereiro e junho, foi até quinze vezes superior à média dos demais meses, representando até 27% do total de atendimentos mensais, o que demonstra a magnitude da sobrecarga imposta à rede de urgência e emergência durante os períodos epidêmicos.

O aumento das demandas assistenciais tem sido acompanhado pela elevação significativa dos custos. Entre 2022 e 2024, as despesas em saúde do município cresceram cerca de R$1,5 bilhão, totalizando R$6,3 bilhões em 2024, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Embora o desemprego tenha recuado para 9,5% em 2023, apenas 67,5% da população economicamente ativa de Belo Horizonte possuía carteira assinada em 2021, o menor patamar desde 2006 (FJP, 2024). O crescimento do trabalho informal amplia a vulnerabilidade social e tende a aumentar a demanda por serviços públicos de saúde, uma vez que reduz a cobertura de planos privados e a proteção previdenciária da população.

A distribuição territorial da população vinculada ao SUS-BH revela desigualdades marcantes entre as regionais administrativas. Regiões periféricas e populosas, como Nordeste, Barreiro e Venda Nova, apresentam maior dependência do sistema público, exigindo ampliação da cobertura da Atenção Primária e fortalecimento das redes de urgência e especializada. Em contraste, a região Centro-Sul apresenta menor dependência, associada ao perfil socioeconômico mais favorecido e maior acesso à saúde suplementar. Essa desigualdade reforça a importância de políticas públicas orientadas pela equidade, capazes de adequar a oferta de serviços à realidade de cada território.

Em síntese, a realidade atual do SUS-BH evidencia um conjunto de desafios estruturais e financeiros que comprometem a eficiência e a capacidade de resposta do sistema. A superação desses problemas requer investimentos coordenados em infraestrutura física, tecnológica e de gestão, que promovam a modernização das unidades, a interoperabilidade de sistemas, a qualificação da vigilância e o fortalecimento da governança da informação. Tais ações são indispensáveis para consolidar um sistema público de saúde moderno, resiliente e equitativo, capaz de responder de forma efetiva às necessidades atuais e futuras da população de Belo Horizonte.

1. 2. 3. **Solução:**

O projeto propõe um conjunto integrado de ações estruturantes voltadas à modernização, expansão e qualificação da Rede SUS-BH. Busca ampliar a capacidade assistencial, aprimorar a infraestrutura física e tecnológica e fortalecer os mecanismos de vigilância e gestão. As soluções apresentadas respondem de forma direta aos problemas e necessidades identificados, articulando investimentos em infraestrutura, inovação e aprimoramento da gestão pública em saúde. A proposta está organizada a partir de soluções interdependentes, que reúnem intervenções físicas, tecnológicas, institucionais e de governança para tornar o sistema de saúde municipal mais eficiente, sustentável e resiliente.

As entregas planejadas do Programa estão organizadas em quatro componentes, que serão detalhados posteriormente. Cabe destacar, entretanto, que a totalidade dos recursos pleiteados está direcionada ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e dos serviços especializados de média e alta complexidade. O Componente 1 é exclusivamente dedicado à APS, prevendo a ampliação e a qualificação da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, concomitantemente ao fortalecimento do modelo já adotado de Parceria Público-Privada para esse nível de atenção no município. O Componente 2 destina-se à ampliação e ao aprimoramento da infraestrutura de unidades de atendimento especializado e de urgência e emergência, além de contemplar melhorias

em unidades de apoio. Quanto às unidades de apoio, destaca-se o seu papel estratégico para o pleno funcionamento e abastecimento da rede de saúde, uma vez que são responsáveis por atividades de manutenção e apoio logístico, assegurando a operacionalidade de toda a cadeia assistencial, desde a APS até os serviços especializados.

O Componente 3 contempla avanços tecnológicos de caráter transversal, abrangendo a implementação de serviços de telessaúde, modelos preditivos e outras ferramentas inteligentes de gestão. Além disso, promove a modernização da assistência na APS, nos serviços especializados e nas unidades de urgência e emergência, contribuindo para a otimização, o correto referenciamento e o atendimento oportuno dos usuários nos diferentes níveis de atenção. Ainda neste componente, a educação em saúde possui como público dedicado os profissionais da APS e dos serviços especializados, permitindo a personalização de conteúdos de acordo com as diretrizes específicas de cada ponto da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Ressalta-se que tais investimentos tecnológicos e de qualificação profissional possuem finalidade exclusivamente assistencial, voltada ao aprimoramento do cuidado prestado nesses níveis de atenção, reforçando o caráter integralmente finalístico do Programa.

Dessa forma, as soluções propostas asseguram que os investimentos em infraestrutura, equipamentos e tecnologia estejam alinhados ao fortalecimento da rede assistencial, à qualificação do cuidado prestado à população e à promoção de uma gestão integrada, eficiente e sustentável do sistema municipal de saúde. Considerando que 100% dos recursos do Programa se destinam à estruturação e qualificação da Atenção Primária e da Atenção Especializada, o pleito enquadra-se nos critérios de priorização estabelecidos pela Cofiex, fazendo jus à atribuição de pontuação adicional prevista para iniciativas integralmente voltadas à assistência à saúde.

- Ampliação e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde SUS-BH por meio da Parceria Público-Privada (PPP)

Esta solução compreende a reconstrução e equipagem de 21 novas Unidades de Atenção Primária à Saúde, no âmbito da Parceria Público-Privada da Atenção Primária — a primeira do país voltada exclusivamente a esse nível de atenção. O modelo adotado transfere à concessionária a responsabilidade pelas obras, manutenção e serviços de apoio não assistenciais, permanecendo a gestão e o atendimento clínico sob responsabilidade do SUS-BH. Essa divisão otimiza a eficiência operacional, permitindo que a gestão pública concentre esforços na qualidade do cuidado, enquanto o parceiro privado assegura infraestrutura moderna e manutenção permanente. As unidades seguem padrão construtivo de aproximadamente mil metros quadrados, com acessibilidade universal, sustentabilidade ambiental e ambiência acolhedora, abrigando até seis equipes de Saúde da Família. O modelo já é referência nacional e demonstrou alto desempenho na resposta a emergências sanitárias, como na pandemia de Covid-19 e nas epidemias de arboviroses. Além da expansão física, esta solução inclui ações voltadas ao fortalecimento da governança das PPPs, com capacitação técnica, consultorias especializadas, elaboração de manuais de governança e monitoramento permanente do desempenho contratual. Também estão previstos estudos de modelagem e elaboração de um Manual de Boas Práticas para subsidiar a ampliação da PPP e a estruturação de novos projetos, como as Unidades de Pronto Atendimento, consolidando Belo Horizonte como referência em parcerias público-privadas na saúde.

- Ampliação e consolidação dos serviços especializados e de urgência

Outra frente de atuação do projeto envolve a expansão, modernização e requalificação da rede assistencial em diferentes níveis de atenção, fortalecendo a capacidade de resposta e a integração dos serviços. Inclui a construção e equipagem de três novos Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs), a reconstrução de dois CERSAMs e quatro Centros de Reabilitação (CREABs), além da construção e equipagem de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As intervenções visam ampliar a cobertura, garantir ambientes adequados, seguros e humanizados e promover a integralidade do cuidado. Esse conjunto de ações inclui ainda a reconstrução e equipagem da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ/CCZ), assegurando condições aprimoradas de biossegurança e diagnóstico laboratorial, e a reforma e equipagem de duas Centrais de Esterilização de Cães e Gatos, com implantação de uma nova unidade. Essas iniciativas ampliam a cobertura territorial e fortalecem o controle de zoonoses e agravos de relevância sanitária. De forma complementar, será realizada a reconstrução de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), ampliando a capacidade de atendimento em especialidades odontológicas, assim como a reconstrução do Almoxarifado Central da Saúde, infraestrutura essencial para a logística, o armazenamento e a distribuição de insumos da rede SUS-BH. Todas as obras contarão com supervisão técnica, ambiental e social, garantindo qualidade, conformidade normativa e mitigação de impactos.

- Modernização, ampliação e qualificação do cuidado e da gestão em saúde

O projeto também incorpora um conjunto de soluções voltadas à transformação digital, inovação tecnológica e fortalecimento da telessaúde, pilares de uma gestão moderna e baseada em evidências. Está prevista a implantação da Central Municipal de Telessaúde, integrando os serviços existentes e garantindo interoperabilidade e conectividade segura entre unidades, ampliando o acesso da população a consultas e pareceres especializados. Essa iniciativa fortalecerá a Atenção Primária, reduzindo deslocamentos e aumentando a resolutividade assistencial. Inclui-se ainda a implantação de um sistema informatizado de coleta e análise de dados de zoonoses, que permitirá o monitoramento epidemiológico em tempo real e a resposta ágil a emergências sanitárias. Outra ação estratégica é a digitalização de mais de 31 mil prontuários físicos e a eliminação de documentos inativos, assegurando rastreabilidade e governança da informação. A proposta inclui ainda a implantação de um sistema integrado de gestão de custos, articulado aos módulos de Recursos Humanos, Contratos e Compras, possibilitando a gestão orçamentária baseada em evidências e o uso racional dos recursos públicos. Serão desenvolvidos modelos preditivos de demanda e capacitação de profissionais para o uso das novas ferramentas, promovendo sustentabilidade institucional e inovação contínua. Esse conjunto de iniciativas consolida um ambiente digital integrado e inteligente, alinhado às diretrizes do SUS Digital e às boas práticas internacionais de governança em saúde.

1. 2. 7. **Resultado:**

Com a execução do projeto espera-se alcançar resultados concretos, mensuráveis e sustentáveis, refletindo-se em avanços significativos para a população e para a gestão pública municipal. As intervenções previstas buscam consolidar um sistema de saúde mais acessível, resolutivo e eficiente, assegurando melhores condições de atendimento, infraestrutura moderna e gestão qualificada em todos os níveis de atenção.

O conjunto de soluções voltadas à ampliação e ao fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde SUS-BH por meio da Parceria Público-Privada compreende a construção e o funcionamento de novas Unidades de Atenção Primária à Saúde. A entrega dessas unidades, devidamente equipadas e operacionais, resultará na ampliação do acesso e da cobertura assistencial, com a redução de vazios territoriais e o fortalecimento da coordenação do cuidado. Espera-se a melhoria da resolutividade e da qualidade da atenção primária, com unidades modernas, sustentáveis e adequadas às necessidades locais, o que contribuirá para o fortalecimento do vínculo entre a população e os serviços, bem como para maior satisfação dos usuários.

Outro conjunto de soluções proposto trata da ampliação e consolidação dos serviços especializados e de urgência, abrange subcomponentes voltados à Rede de Saúde Mental, Reabilitação, Urgência e Vigilância em Saúde/Zoonoses. A requalificação e expansão de unidades como CERSAMs, CREABs, UPAs e equipamentos de vigilância e controle de zoonoses permitirá o aumento da capacidade assistencial, a redução de filas e tempos de espera, e a melhoria das condições estruturais e de biossegurança. A modernização das instalações e a integração em rede fortalecerão a capacidade resolutiva e a resposta rápida às demandas de saúde mental, reabilitação e vigilância, garantindo atenção integral e de qualidade à população.

Um terceiro conjunto de soluções concentra-se na modernização da infraestrutura tecnológica e no aprimoramento dos processos de gestão. A implantação de sistemas digitais integrados, ferramentas de gestão de custos e modelos preditivos, associada à expansão dos serviços de Telessaúde, promoverá a digitalização de processos, o fortalecimento da eficiência administrativa, a transparência e a segurança da informação. Espera-se alcançar integração tecnológica entre os níveis assistenciais, ampliando o acesso da população a especialistas por meio do atendimento remoto e reduzindo deslocamentos desnecessários. As ações também buscam adequar os processos de trabalho da vigilância e controle de zoonoses à modernização das ferramentas de registro e análise de dados, assegurando que o município permaneça na vanguarda das ações de monitoramento, prevenção e controle de doenças emergentes e reemergentes.

De forma transversal, o projeto deverá gerar impactos positivos em múltiplas dimensões. Entre os resultados esperados destacam-se o fortalecimento da vigilância epidemiológica, a valorização dos trabalhadores da saúde e a consolidação de uma cultura institucional orientada pela inovação, pela gestão baseada em evidências e pela sustentabilidade. As ações também produzirão externalidades positivas relacionadas à melhoria da infraestrutura urbana, ao estímulo à economia local e à consolidação de Belo Horizonte como referência nacional em gestão e inovação em saúde pública.

O alcance desses resultados será monitorado de forma sistemática, por meio de indicadores de desempenho, metas físicas e financeiras e relatórios periódicos de acompanhamento, assegurando a avaliação contínua dos impactos sobre a qualidade, a eficiência e a equidade do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

Contribuir para a melhoria sustentável das condições de saúde da população de Belo Horizonte, por meio do fortalecimento e qualificação da rede de atenção à saúde, da ampliação do acesso e da incorporação de modelos inovadores de cuidado, promovendo serviços mais integrais e orientados às necessidades dos usuários.

(ii) Objetivos Específicos

1. Fortalecer e expandir a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso e a capacidade resolutiva.

Correlação:

- Componente 1
- Objetivos Estratégicos do PPA: OE 101, 102, 106, 107, 111, 202 e 302.
- Indicadores: 1, 2 e 3

2. Ampliar e consolidar a Rede Especializada e de Urgência, garantindo cuidado integral e qualificado.

Correlação:

- Componente: 2
- Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102, 106, 107, 111, 202 e 302.
- Indicadores: 4, 5, 6 e 7

3. Modernizar a gestão do sistema de saúde e incorporar tecnologias e modelos inovadores de cuidado.

Correlação:

- Componente: 3 - Subcomponente 3.1 e 3.2
- Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102, 206, 302, 303.
- Indicadores: 8

4. Fortalecer a formação, o desenvolvimento profissional e a educação permanente em saúde.

Correlação:

-

Componente: 3 - Subcomponente 3.3

- Objetivos Estratégicos do PPA: OE 102, 206, 302, 303.
- Indicadores: 9

Síntese das correlações dos Objetivos Específicos

Objetivo Geral	Contribuir para a melhoria sustentável das condições de saúde da população de Belo Horizonte, por meio do fortalecimento e qualificação da rede de atenção à saúde, da ampliação do acesso e da incorporação de modelos inovadores de cuidado, promovendo serviços mais integrais e orientados às necessidades dos usuários.				
Objetivos Específicos	**Componentes**	**Subcomponentes**	**Produtos**	**Objetivo Estratégico PPA/GOV BR 2024/2027**	**Indicadores**
1. Fortalecer e expandir a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso e a capacidade resolutiva	Componente 1.0- Ampliação e fortalecimento da rede de atenção à saúde SUS-BH por meio da Parceria Público Privado	(S) 01 Construção de unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) através da Parceria Público Privada	P.1.1.1 P.1.1.2	101-102-106 - 107-111-202 302	1-2-3
		(S) 02 Fortalecimento e capacitação da gestão contratual da Parceria Público Privada	P.1.2.1 P.1.2.2 P1.2.3 P.1.2.4		
		(S) 03 Realização de estudos de modelagem para ampliação da Parceria Público Privada	P.1.3.1		

2. Consolidar a Rede Especializada e de Urgência, garantindo cuidado integral e qualificado	Componente 2.0 - Ampliação e consolidação dos serviços especializados e de urgência	(S) 01- Construção de unidades da Rede Especializada e de Urgência	P.2.1.1 P.2.1.2 P.2.1.3 P.2.1.4 P.2.1.5 P.2.1.6	102-106-107 111-202-302	4 -5-6-7
		(S) 02 - Aparelhar as unidades da Rede Especializada e de Urgência	P.2.2.1 P.2.2.2		
3. Modernizar a gestão do sistema de saúde e incorporar tecnologias e modelos inovadores de cuidado	Componente 3.0 - Modernização, ampliação e qualificação do cuidado e gestão em saúde	(S) 01 - Transformação Digital e Telessaúde na rede SUS-BH	P.3.1.1 P.3.1.2	102-206--302 303	8
		(S) 02 - Modernização dos serviços de gestão em saúde	P.3.2.1 P.3.2.2 P.3.2.3 P.3.2.4 P.3.2.5		
4. Fortalecer a formação, o desenvolvimento profissional e a educação permanente em saúde	Componente 3.0 - Modernização, ampliação e qualificação do cuidado e gestão em saúde	(S) 03 - Modernização e Fortalecimento da Educação Permanente em Saúde na rede SUS-BH	P.3.3.1 P.3.3.2 P.3.3.3 P.3.3.4	102-206-302 303	9

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Atendimentos à população realizados na Atenção Primária à Saúde

Descrição:

Nome do Indicador 1	**Atendimentos à população realizados na Atenção Primária à Saúde**
Descrição	Mede a produção, a capacidade de oferecer o primeiro contato de cuidado em saúde ao usuário no território e o potencial de trabalho das equipes de saúde da APS. Além de ser útil para analisar a capacidade operacional, sobrecarga ou subutilização e o impacto da (s) unidade (s) na rede.
Fórmula de cálculo	Atendimentos na APS (ano) = somatório de atendimentos realizados (ano)
Objetivos Específicos da Proposta	1. Fortalecer e expandir a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso e a capacidade resolutiva.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social. 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões. 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência. 111. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. 202. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
Fonte de dados	SIGRAH/SMSA
Linha de Base	6.635.191 atendimentos/ano (2024) (Origem: Relatório Anual de Gestão - 2024)
Unidade de Medida	Número de atendimentos
Meta	Aumentar o número de atendimentos anuais realizados pela Atenção Primária à Saúde (APS) em 22%, alcançando 8.139.950 atendimentos/ano até 2030.

Meta:
Aumentar o número de atendimentos anuais realizados pela Atenção Primária à Saúde (APS) em 22%, alcançando 8.139.950 atendimentos/ano até 2030.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAPs)

Descrição:

Nome do Indicador 2	**Taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAPs)**
Descrição	Mede a capacidade do sistema de saúde em gerenciar condições crônicas e prevenir o agravamento de doenças na atenção básica, evitando a necessidade de hospitalização.
Fórmula de cálculo	Percentual de ICSAPs = (Número de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária ÷ Total de Internações Hospitalares) x 100
Objetivos Específicos da Proposta	1. Fortalecer e expandir a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso e a capacidade resolutiva
Referência ao PPA 2024–2027	101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social.; 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.; 106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.; 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.; 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
Fonte de dados	SIH/DATASUS
Linha de Base	25,97% (2024) – Origem: Plano de Saúde Belo Horizonte 2026–2029
Unidade de Medida	Percentual
Meta	Reduzir a Taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAPs) em 15% até 2030, em relação à linha de base

Meta:
Reduzir a Taxa de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAPs) em 15% até 2030, em relação à linha de base.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Mortalidade prematura pelas principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) padronizada por idade
Descrição:

Nome do Indicador 3	**Mortalidade prematura pelas principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) padronizada por idade**
Descrição	Mede o impacto dos óbitos por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) em uma população que ainda estava na idade produtiva (30 a 69 anos), sinalizando perdas precoces de vida que poderiam ter sido evitadas com políticas de prevenção, controle e tratamento eficazes.
Fórmula de Cálculo	Taxa de mortalidade prematura por DCNT = (Número de óbitos por DCNT de pessoas com 30 a 69 anos/população residente de 30 a 69 anos) x 100.000

Objetivos Específicos da Proposta	1. Fortalecer e expandir a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso e a capacidade resolutiva.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social. 102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
Fonte de Dados	SIM-DATASUS (MS), IBGE e DPSV (SMSA)
Linha de Base	204,80 (2025) (Plano Plurianual de Gestão 2026-2029)
Unidade de Medida	Óbitos por DCNT por 100.000 residentes
Meta	Reduzir a Mortalidade prematura pelas principais DCNTs em 4,88% até 2030, em relação à linha de base.

Meta:
Reduzir a Mortalidade prematura pelas principais DCNTs em 4,88% até 2030, em relação à linha de base.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Atendimentos à População na Rede de Saúde Mental
Descrição:

Nome do Indicador 4	**Atendimentos à População na Rede de Saúde Mental**
Descrição	Mede o volume total de atendimentos prestados pelos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde (SUS) a população. O principal objetivo é mensurar a capacidade de oferta e o acesso da população aos cuidados em saúde mental.
Fórmula de Cálculo	Atendimentos na rede de saúde mental (ano) = somatório de atendimentos na rede de saúde mental realizados (ano)
Objetivos Específicos da Proposta	2. Consolidar a Rede Especializada, garantindo cuidado integral e qualificado.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões. 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência. 111. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.

Fonte de Dados	SIGRAH/SMSA
Linha de Base	443.508 atendimentos/ano (2024) (Origem: Relatório Anual de Gestão - 2024)
Unidade de Medida	Número de atendimentos
Meta	Atingir 480.000 de atendimentos/ano realizados pela Rede de Saúde Mental, até o final de 2030.

Meta:
Atingir 480.000 de atendimentos/ano realizados pela Rede de Saúde Mental, até o final de 2030.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Atendimentos à População nas Unidades de Pronto Atendimento
Descrição:

Nome do Indicador 5	**Atendimentos à População nas Unidades de Pronto Atendimento**
Descrição	Mede o volume total de atendimentos prestados pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) à população. O principal objetivo é mensurar a capacidade de oferta e o acesso da população aos serviços ofertados por essas unidades especialistas no atendimento de urgências e emergências.
Fórmula de Cálculo	Atendimentos nas UPAs (ano) = somatório de atendimentos realizados nas UPAs (ano)
Objetivos Específicos da Proposta	2. Consolidar a Rede Especializada, garantindo cuidado integral e qualificado.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões. 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência. 111. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. 202. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
Fonte de Dados	SIGRAH/SMSA
Linha de Base	932.721 atendimentos/ano (2024) (Origem: PPAG - 2024)
Unidade de Medida	Número de atendimentos

Meta	Aumentar o número de atendimentos anuais realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) em 12,6%, alcançando 1.050.000 atendimentos/ano até 2030.

Meta:
Aumentar o número de atendimentos anuais realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) em 12,6%, alcançando 1.050.000 atendimentos/ano até 2030.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Exames de Mamografia realizados no município
Descrição:

Nome do Indicador	**Exames de Mamografia realizados no município**
Descrição	Indicador que expressa o número total de exames de mamografia realizados nos estabelecimentos de saúde localizados no município, em determinado período. É utilizado para monitorar a produção de serviços, a oferta assistencial e a capacidade instalada da rede de saúde, contribuindo para o aprimoramento da atenção especializada, especialmente no fortalecimento das ações de diagnóstico e rastreamento do câncer de mama.
Fórmula de Cálculo	Total de Exames = somatório de mamografias realizadas por município de atendimento no período
Objetivos Específicos da Proposta	2. Consolidar a Rede Especializada, garantindo cuidado integral e qualificado.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
Fonte de Dados	SISCAN/DATASUS
Linha de Base	63.394 exames de mamografia (competência 2025) (Origem: SISCAN/DATASUS)
Unidade de Medida	Número de exames realizados no município.
Meta	Aumentar o número de exames de mamografia realizados no município em 25%, ou seja, atingindo 79.242 exames/ano até 2030.

Meta:
Meta: Aumentar o número de exames de mamografia realizados no município em 25%, ou seja, atingindo 79.242 exames/ano até 2030.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Atendimentos à População nos Centros de Reabilitação

Descrição:

Nome do Indicador 7	**Atendimentos à População nos Centros de Reabilitação**
Descrição	Mede a produção assistencial realizada nos Centros de Reabilitação (CREABS) à pessoas com alguma deficiência ou necessidades de reabilitação. É importante monitorar a utilização e a demanda pelos serviços de reabilitação, a capacidade instalada e a necessidade de ampliação da oferta.
Fórmula de Cálculo	Atendimentos realizados pelos CREABs = somatório de atendimentos realizados nos CREABs (ano)
Objetivos Específicos da Proposta	2. Consolidar a Rede Especializada, garantindo cuidado integral e qualificado.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões. 107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência. 111. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.
Fonte de Dados	SIA-SUS/DATASUS
Linha de Base	275.353 atendimentos (nov 2024-out 2025) (Origem: SIA-SUS/DATASUS)
Unidade de Medida	Número de atendimentos
Meta	Aumentar o número de atendimentos anuais realizados pelos Centros de Reabilitação (CREABs) em 25%, ou seja, atingindo 344.141 atendimentos/ano, até 2030.

Meta:
Aumentar o número de atendimentos anuais realizados pelos Centros de Reabilitação (CREABs) em 25%, ou seja, atingindo 344.141 atendimentos/ano, até 2030.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Consultas ofertadas por meio de teleatendimento
Descrição:

Nome do Indicador 8	**Consultas ofertadas por meio de teleatendimento**
Descrição	Mede de forma geral, a produção, a capacidade de acesso a atendimentos não presenciais, a ampliação das formas de cobertura e o desempenho dessa modalidade a partir da quantificação do número total de consultas utilizando os recursos de teleatendimentos, ofertados remotamente pelos serviços de saúde.

Fórmula de Cálculo	Teleatendimentos ofertados (ano) = somatório de teleatendimentos ofertados (ano)
Objetivos Específicos da Proposta	3. Modernizar a gestão do sistema de saúde e incorporar tecnologias e modelos inovadores de cuidado.
Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 206. Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado- institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional. 303. Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Fonte de Dados	DAUE/SMSA
Linha de Base	58.858 (2024) (Origem: DAUE/SMSA)
Unidade de Medida	Número de teleatendimento ofertado
Meta	Atingir 120.000 ofertas anuais de consultas por meio de teleatendimento até 2030, representando um aumento >103% em relação à linha de base.

Meta:
Atingir 120.000 ofertas anuais de consultas por meio de teleatendimento até 2030, representando um aumento >103% em relação à linha de base.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Certificações emitidas pelo Programa de Educação Permanente (PROEP)

Descrição:

Nome do Indicador 9	**Certificações emitidas pelo Programa de Educação Permanente (PROEP)**
Descrição	Mede o número de certificações emitidas pelo Programa de Educação Permanente (PROEP) aos trabalhadores da saúde que concluíram ações formativas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. O indicador permite acompanhar o alcance, a efetividade e a adesão às iniciativas de qualificação profissional, contribuindo para avaliar o fortalecimento das competências técnicas e a consolidação da política de educação permanente no município.
Fórmula de Cálculo	Certificações emitidas PROEP = somatório de certificações emitidas nas ações formativas do PROEP no período
Objetivos Específicos da Proposta	4. Fortalecer a formação, o desenvolvimento profissional e a educação permanente em saúde.

Referência ao PPA 2024-2027 Nacional (Objetivo Estratégico PPA)	102. Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 206. Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação. 302. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional. 303. Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.
Fonte de Dados	DESA/SMSA
Linha de Base	13.951 (2024) (Origem: DESA-SMSA)
Unidade de Medida	Número de certificações emitidas
Meta	Emitir, até 2030, no mínimo 18.000 certificações pelo PROEP, representando aumento de aproximadamente 30% em relação à linha de base.

Meta:
Emitir, até 2030, no mínimo 18.000 certificações pelo PROEP, representando aumento de aproximadamente 30% em relação à linha de base.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Componente 1 - Ampliação e fortalecimento da rede de atenção à saúde SUS-BH por meio da Parceria Público Privada
Valor estimado em Real (BRL): 474.795.000,00

Descrição:
O Componente 1 tem por finalidade promover a ampliação e o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Município de Belo Horizonte, priorizando o nível primário, por meio do regime de Parceria Público-Privada (PPP), visando à requalificação da oferta de serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do SUS-BH. Entre as ações previstas, incluem-se a construção e disponibilização de novas Unidades Básicas de Saúde, o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e fiscalização contratual da PPP e a realização de estudos de modelagem voltados à eventual expansão do modelo atualmente vigente para outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) que se articulam à gestão do cuidado coordenado pela APS. Os recursos oriundos da operação de crédito serão aplicados integralmente no financiamento de despesas necessárias à execução de programa de política pública continuada, em estrita conformidade com os incisos I, II, III, IV e V do art. 9º da Resolução pertinente, que estabelece os critérios técnicos de elegibilidade, enquadramento e avaliação dos projetos submetidos. Espera-se, como resultado, a elevação da qualidade e da resolutividade dos serviços assistenciais ofertados na Atenção Básica, com ganhos expressivos de eficiência operacional e fortalecimento do vínculo dos usuários com a rede SUS-BH, contribuindo para a consolidação de um modelo de atenção mais moderno, integrado e efetivo.

Descrição de subcomponentes e produtos:

(S) SUBCOMPONENTE 01 - Construção de unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) através da Parceria Público Privada

Este subcomponente está focado na Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da construção, equipagem e operação de 20 novas unidades de saúde via Parceria Público-Privada (PPP).

(P) Produto 1.1.1 Construção de 20 Unidades de Atenção Primária à Saúde (APS), entregues equipadas e em funcionamento

Estima-se um valor total de R$40.000.000,00, para este produto, visando a expansão da infraestrutura da Atenção Primária à Saúde (APS) mediante a construção de 20 unidades, no valor de R$2.000.000,00 para cada, a serem entregues equipadas e em funcionamento por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Essas unidades serão incorporadas de maneira a atender às demandas assistenciais da melhor forma possível e buscando também otimizar, a esse pleito assistencial, a adequação de terrenos livres, desimpedidos e de propriedade do município, contemplando os 9 distritos sanitários (regionais de saúde) da cidade, sendo a maioria em regiões de maior vulnerabilidade social. A estrutura dessas unidades é edificada em Light Steel Frame (LSF), possui 02 (dois) ou 03 (três) pavimentos, paredes internas em placas de gesso acartonado e placas cimentícias externas, telhado com estrutura metálica, totalizando área total construída de, aproximadamente, 1.000m², planejada para abrigar até 06 (seis) equipes de Saúde da Família (eSF), se contrapondo com a estrutura atual dos Centros de Saúde (CSs) que comportam até 04 (quatro) eSF, e garantindo a ampliação da capacidade de atendimento à população.

Os preceitos básicos do projeto das construções garantem conforto aos usuários e funcionários, identidade visual própria, uso de tecnologias sustentáveis e revestimento de fácil higienização, acessos independentes, ambientes humanizados, com número suficiente de consultórios e salas que suportam o incremento de recursos humanos, e que atendam às legislações e normas vigentes. Dessa forma, as unidades possuirão recepção, 12 (doze) consultórios para as 06 (seis) equipes de Saúde da Família; 03 (três) consultórios de apoio indiferenciado (comporta atendimento de diferentes especialidades), consultório de apoio ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF), consultório ginecológico, farmácia, salas de espera, coleta, triagem, sala de vacina, de observação e curativo, ambiente para higienização, 06 (seis) consultórios odontológicos, escovário e contará com implantação de áreas administrativas, almoxarifado, sala multiuso, utilidades, copa, depósito de material de limpeza (DML), vestiários, instalações sanitárias com acessibilidade, espaços para agentes comunitários de saúde, para agentes de controle de epidemias, dentre outros ambientes. Todos os ambientes serão climatizados, mesmo aqueles em que não há obrigação normativa para tal, garantindo conforto aos profissionais e usuários e melhores condições de atendimento.

Cabe destacar que há um contrato de concessão, com execução iniciada em 2019 para construção e reconstrução de Centros de Saúde e, em outubro de 2025, foi firmado com a concessionária o 16º Termo Aditivo. O método construtivo utilizado se mostrou eficiente e rápido, de forma que o prazo para conclusão das obras é de até um ano após seu início.

(P) Produto 1.1.2 Contraprestação de 20 Unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) entregues por meio da Parceria Público Privada

Esse produto assegura a continuidade das ações propostas no produto 1.1.1, garante a operacionalidade da Atenção primária à Saúde (APS) e maximiza os benefícios e impactos sociais por meio da previsão de contraprestação das 20 unidades de APS construídas na modalidade de PPP financiadas neste programa e nas unidades já existentes. Para tanto, há um valor total de R$420.225.000,00, distribuído ao longo dos 5 anos do programa, aí incluídos os R$156.750.000,00 a serem apresentados como contrapartida local.

A contraprestação é definida no valor máximo anual e mensal do Contrato. Ela é composta por uma parcela fixa de 75% e uma parcela variável de 25%, atrelada aos indicadores do sistema de mensuração de desempenho, no qual o Verificador Independente (empresa contratada pelo Poder Concedente, nos termos do próprio Contrato de Concessão) valida o valor da chamada contraprestação efetiva, que considera a quantidade de unidades em operação. Ainda, mensalmente, o Verificador Independente também valida previamente o pagamento, quando do envio das notas fiscais de cobrança da contraprestação pela Concessionária. Esse valor de contraprestação considera valores individuais para cada Centro de Saúde, que variam entre os termos aditivos aos quais foram inseridos, considerando o chamado fator de operação; e considera também o pagamento referente à climatização nessas unidades, promovida pelo 9º termo aditivo do contrato de concessão.

Essa contraprestação abrange:

- despesas de apoio não assistenciais prestadas pela Concessionária nas unidades;
- gestão de riscos e seguros, que engloba toda a repartição de riscos do contrato, implicando na cobertura de danos à infraestrutura, construção, variação de taxas de câmbio e demais riscos especificados

contratualmente, bem como os seguros obrigatórios da concessão para cobrir risco de engenharia, danos materiais, responsabilidade civil e outros especificados contratualmente;

- parcela de despesas para garantir a dinâmica de funcionamento da unidade, considerando que o aporte inicial pago é uma parte do custo total da obra e dos equipamentos.

Em relação aos serviços não assistenciais a cargo da Concessionária, além da edificação, temos:

- Gestão da edificação (engenharia, conservação da infraestrutura, funcionamento de equipamento de acessibilidade, climatização em todos os ambientes, CFTV e Segurança Patrimonial);
- Sustentabilidade da unidade (captação de água pluvial, aquecimento solar);
- Garantia das atividades de hotelaria (lavanderia, descartáveis, jardinagem, controle de pragas, limpeza e higiene);
- Organização do atendimento (Central de Atendimento);
- Funcionamento das estruturas e equipamentos (mobiliário e equipamentos clínicos).

A Cartilha Orientadora sobre o Contrato de PPP da APS, elaborada para os gerentes das unidades PPP (que são também formalmente designados como assistentes à fiscalização do Contrato), detalha melhor o escopo dos serviços da Concessionária e o acompanhamento do Contrato, inclusive pelo Verificador Independente em relação aos indicadores que afetam diretamente a parcela variável da contraprestação. É importante ressaltar que todos os serviços assistenciais, incluindo insumos utilizados e serviços de TI são prestados diretamente pela Prefeitura de Belo Horizonte.

(S) SUBCOMPONENTE 02 - Fortalecimento e capacitação da gestão contratual da Parceria Público Privada

No Subcomponente 02 o foco passa a ser a gestão estratégica e a governança para fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS).

(P) Produto 1.2.1 Capacitação para certificação internacional em Parcerias Público Privadas

Está previsto um valor de R$300.000,00 voltados à Atenção Primária à Saúde (APS) para contratação de cursos de modelagem, MBAs, e cursos preparatórios, oferecidos na língua português do Brasil, e realização de exame para certificação internacional CP³P (Foundation) com o intuito de capacitar e padronizar competências da equipe técnica da SMSA podendo-se também expandir para outros atores-chave envolvidos na governança e processos diversos da PPP.

Atualmente, a capacitação pensada para a certificação CP³P é fornecida pela consultoria Radar PPP, sendo que a certificação em si pode ser adquirida de outras formas. A certificação internacional possui três níveis - https://radarppp.com/treinamentos/cp3p/ - e pode ser obtida independente da contratação da capacitação (treinamento), embora o treinamento seja crucial para o processo de aprendizado e ganho de conhecimento pretendido. O objetivo com a certificação CP³P é garantir que a equipe esteja alinhada às melhores práticas de gestão e fiscalização dos contratos.

(P) Produto 1.2.2 Acompanhamento jurídico, econômico financeiro e operacional contínuo para apoio à gestão e fiscalização do contrato da Parceria Público Privada

Considerando que o contrato de PPP, da Atenção Primária à Saúde (APS), requer revisão periódica de fluxos e modelos financeiros, simulações de sensibilidade, elaboração de reuniões e pareceres técnicos, podendo incorrer em licitações e renegociações, faz-se necessária a contratação de profissional (economista/analista financeiro) com experiência em PPPs e, principalmente, modelagem econômico?financeira para dar suporte e apoio aos gestores e fiscais do contrato. O formato de contratação deste profissional será por retainer mensal, seguindo moldes similares aos de contratação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

Ademais, será necessária a contratação de consultoria técnica (PBH Ativos), na modalidade remota, com entregas periódicas, para suporte mensal pontual da operação, notadamente sob o ponto de vista jurídico, em complemento à

atuação da própria Procuradoria-Geral do Município, bem como para o tratamento de assuntos diversos envolvendo equilíbrio econômico-financeiro, elaboração de pareceres curtos, realização de reuniões de governança e revisão de indicadores. No que se refere à PBH Ativos, trata-se de empresa pública do Município que presta serviços de apoio à gestão de contratos de PPP, possuindo atualmente termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde para esse fim, com entregas formais realizadas no âmbito deste instrumento. Estima-se um custo total de R$740.000,00 para essas contratações.

(P) Produto 1.2.3 Manual de Governança das Parcerias Público Privadas da rede SUS-BH

Este produto consiste na padronização da governança da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da elaboração de manual institucional, em formato digital, com procedimentos de fiscalização, checklists, matrizes de responsabilidade, modelo de relatórios e fluxos de decisão para os contratos de PPP da SMSA. O custo total estimado é de R$30.000,00, incluindo produção editorial, validação e versão com apoio e revisão constante da equipe interna de PPP da SMSA para garantir aderência e relevância ao conteúdo abordado. Com isso, espera-se reduzir a dependência de conhecimento tácito, padronizar processos e facilitar a capacitação de novos integrantes na equipe. Será avaliada a opção mais viável de aquisição, conforme práticas mercadológicas, sendo plausível a contratação de uma agência ou consultoria especializada para elaboração do produto em prazo determinado.

(P) Produto 1.2.4 Mensuração permanente de desempenho da Parceria Público Privada

Prevê a contratação de Verificador Independente (VI) para as unidades da Atenção Primária à Saúde (APS) com o intuito de avaliar, de forma independente, o desempenho operacional e econômico-financeiro dos contratos de PPPs em curso. Essa avaliação é realizada por meio da comparação de indicadores contratuais, evidências de qualidade e do cumprimento dos níveis de serviço. Trata-se de figura contratualmente prevista e licitada pelo Poder Concedente, que atua em todas as unidades abrangidas pelo contrato de concessão já firmado. O VI atua por meio da entrega de produtos mensais ou trimestrais, os quais contemplam a avaliação do sistema de mensuração de desempenho, a validação do cálculo dos pagamentos à Concessionária e outras ações estipuladas em seu contrato. O custo total previsto para este produto é de R$12.000.000,00.

(S) SUBCOMPONENTE 03 - Realização de estudos de modelagem para ampliação da Parceria Público Privada

O subcomponente 03 dedica-se ao fortalecimento da Média Complexidade assistencial, por meio da estruturação de estudos de modelagem para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), integrantes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, garantindo que o elo intermediário entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Rede Hospitalar possa contar com gestão eficiente, infraestrutura modernizada e sustentabilidade fiscal a longo prazo.

(P) Produto 1.3.1 Modelagem de Parceria Público Privada para Unidades de Pronto Atendimento

Este produto vislumbra a contratação de consultoria para modelagem econômico?financeira para as unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que compõem a Rede de Urgências e Emergências e a Média Complexidade, e que deverá seguir etapas que incluem:

- Diagnóstico e definição do escopo do projeto PPP, com análise da demanda por serviços de saúde, levantamento da situação atual da Unidades de Pronto Atendimento (UPA), dos ativos existentes e das necessidades de investimento, bem como a verificação de aderência às políticas públicas e ao marco legal aplicável;

- Desenvolvimento de estudos de viabilidade, que envolvem a modelagem técnica e operacional (definição dos serviços a serem delegados ao parceiro privado, níveis de serviço, indicadores de desempenho e matriz de riscos), a modelagem econômico-financeira (estimativa de CAPEX e OPEX, projeção de receitas e contraprestações públicas, análise de sustentabilidade financeira e de value for money) e a modelagem jurídica (estrutura contratual, prazos, garantias, mecanismos de pagamento, penalidades e hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro);

- Realização de análises de riscos e de alocação eficiente entre as partes, além de consultas e, quando aplicável, audiências públicas para aprimoramento do projeto e aumento da transparência;

- Consolidação dos estudos para elaboração do edital e do contrato, suporte ao processo licitatório e, em alguns casos, na fase inicial de implantação do modelo, assegurando que a PPP seja viável, atrativa ao mercado e alinhada ao interesse público.

Dessa forma, as entregas do produto deverão compreender: modelo financeiro em Excel com cenários e resultados; matriz de riscos com propostas de alocação; minuta contratual / termo de referência / anexos técnicos; relatório final e apresentação executiva. O produto deverá se concretizar no prazo de seis a doze meses, pressupondo a disponibilidade de dados, a participação dos stakeholders e a definição de marcos com entregas parciais.

Para tanto, foi estimado um custo total de R$1.500.000,00 a ser pago nos anos 2 e 3 do Programa.

1. 5. 14. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 2 - Ampliação e consolidação dos serviços especializados e de urgência e emergência
Valor estimado em Real (BRL): 222.117.000,00

Descrição:
O Componente 2 tem por finalidade ampliar e qualificar a oferta de serviços especializados, bem como de urgência e emergência, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH). O objetivo central do componente consiste na construção de novas unidades e na reforma, ampliação e adequação das unidades já existentes, de forma integrada à incorporação de bens, equipamentos e soluções tecnológicas estratégicas. As intervenções propostas visam à modernização da infraestrutura assistencial e ao fortalecimento da capacidade operacional da rede, garantindo maior eficiência, resolutividade e integração entre os diferentes níveis de atenção. Espera-se, como resultado, o aprimoramento das condições físicas e tecnológicas dos serviços, o aumento da capacidade de resposta às demandas de saúde mental, reabilitação, vigilância em saúde e atendimento de urgência e emergência. Adicionalmente, o componente contribui para a ampliação do acesso oportuno, o aumento da segurança do paciente e a elevação dos padrões de qualidade assistencial ofertados à população, em consonância com os princípios do SUS e com as diretrizes de regionalização e integralidade da atenção à saúde.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) SUBCOMPONENTE 01 - Construção de unidades da Rede Especializada e de Urgência

(P) Produto 2.1.1 Construção de 1 Unidade de Saúde Especializada

A construção da unidade especializada objeto do presente produto refere-se à implantação do Centro de Referência em Saúde Mental da Regional Centro-Sul (CERSAM Centro-Sul). A Regional Centro-Sul de Belo Horizonte possui uma população estimada em aproximadamente 300 mil habitantes e, mesmo concentrando a maior inserção no mercado formal e maior acesso à rede suplementar de saúde, ela se caracteriza por expressivos níveis de vulnerabilidade e desigualdade social, especialmente no que se refere às condições de moradia, acesso a serviços públicos e presença significativa de pessoas em situação de rua (PSR). Essa regional abriga cerca de 31% da população em situação de rua do município, o que corresponde a aproximadamente 4 mil pessoas, majoritariamente concentradas em áreas próximas ao hipercentro da cidade.

Atualmente, a Regional Centro-Sul não dispõe de um equipamento próprio de referência em saúde mental, o que resulta no direcionamento de sua demanda assistencial para unidades localizadas nas Regionais Leste e Oeste. Essa dinâmica tem ocasionado sobrecarga nos serviços existentes, dificultando o acesso oportuno e comprometendo a capacidade resolutiva da rede de atenção psicossocial. Nesse contexto, a implantação do CERSAM Centro-Sul mostra-se estratégica, por atender uma área caracterizada como vazio assistencial,e por se localizar em proximidade aos territórios de maior vulnerabilidade social anteriormente mencionados.

A construção da unidade representa uma ação estruturante para a ampliação do acesso e da oferta de serviços de saúde mental, com impacto direto na reorganização do fluxo assistencial e no redimensionamento físico da rede, considerando que a população da Regional Centro-Sul atualmente necessita deslocar-se para outras unidades para atendimento. Ademais, a localização proposta favorece a facilitação do acesso da população em maior situação de vulnerabilidade, contribuindo para a redução de barreiras territoriais e sociais ao cuidado em saúde mental.

A unidade será implantada em terreno de propriedade municipal, já definido, com metragem aproximada de 1200m2, e tem custo orçado de R$16.000.000,00. O projeto arquitetônico contempla infraestrutura completa e adequada às diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), incluindo recepção, consultórios, oito leitos destinados à Hospitalidade Noturna, salas para oficinas terapêuticas, refeitório, pátio para atividades coletivas, além de espaços destinados ao manejo clínico, atividades multiprofissionais e áreas administrativas.

(P) Produto 2.1.2 Construção de 1 Unidade de Urgência e Emergência

A implantação de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em localização estratégica entre as Regionais Norte e Noroeste de Belo Horizonte, ambas caracterizadas por elevados volumes de atendimento, tem por finalidade ampliar e qualificar a oferta de serviços de urgência e emergência, bem como redimensionar o fluxo assistencial nessas regiões. A nova unidade será estruturada para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reduzir desigualdades territoriais, desconcentrar a demanda atualmente absorvida pelas UPAs Norte e Noroeste e assegurar atendimento oportuno, ágil e resolutivo para casos de média complexidade.

Ademais, a UPA atuará como referência intermediária entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e os hospitais da rede SUS-BH, contribuindo para o fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e promovendo maior integração, eficiência e equidade na organização do cuidado à população.

A unidade será classificada como UPA Porte III, com área construída estimada entre 1.300 m² e 1.700 m², em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Sua capacidade instalada permitirá o atendimento de aproximadamente 300 a 500 pacientes por dia, o que corresponde a um volume estimado de até 10.000 atendimentos mensais, considerando o impacto conjunto das duas regionais. O custo estimado para a construção é de R$17.500.000,00, a ser executada em terreno previamente definido pelo Município.

A implantação da nova UPA na Região Noroeste trará benefícios estruturantes para a rede local de saúde, especialmente diante do elevado volume de atendimentos e das condições de vulnerabilidade social presentes no território. Entre os principais ganhos, destacam-se a redução da sobrecarga nas unidades existentes, com consequente diminuição dos tempos de espera e aumento da resolutividade assistencial, bem como a ampliação do acesso aos serviços de saúde em áreas vulneráveis, assegurando atendimento ininterrupto, 24 horas por dia, e contribuindo de forma efetiva para a redução das desigualdades territoriais no acesso aos serviços públicos de saúde.

(P) Produto 2.1.3 Reforma de 1 Unidade Hospitalar

A reforma do bloco cirúrgico do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) integra um conjunto de intervenções estruturantes voltadas à modernização da capacidade assistencial do hospital, identificadas como prioritárias. A proposta do HOB prevê a utilização de recursos para realização de obras de unificação do Centro Cirúrgico do complexo. Atualmente a instituição conta com três espaços para os procedimentos cirúrgicos, a saber: Bloco Cirúrgico I, no primeiro andar do prédio principal, com foco nos atendimentos de urgência e emergência; Bloco Cirúrgico II, no segundo andar do mesmo prédio, porém com foco nos atendimentos eletivos; e a Unidade Hospital Dia Cirúrgico – UHDIA, cujos atendimentos (eletivos) são realizados em edificação do complexo situada em outro endereço. Trata-se, portanto, de intervenção ampla, abrangendo uma ala inteira do prédio principal do HOB, de forma a permitir que todos os procedimentos cirúrgicos sejam realizados nesse novo espaço, e com a realocação dos serviços que, hoje, ocupam o referido ambiente.

A instituição, que atualmente tem 521 leitos ativos e quase 3 mil trabalhadores, oferece serviços cirúrgicos de ortopedia, cirurgia geral, clínica médica e cirurgia vascular. O investimento total estimado para a reforma é de R$16.000.000,00, valor que permitirá a atualização das instalações, a melhoria do fluxo assistencial e a elevação da capacidade resolutiva do hospital, contribuindo para reduzir gargalos, ampliar a segurança e sustentar a continuidade do cuidado em especialidades de alta demanda no SUS-BH, com ganhos de qualidade e desempenho assistencial. O anteprojeto arquitetônico para a unificação do Centro Cirúrgico do complexo HOB já foi elaborado. Atualmente encontra-se em andamento o detalhamento do projeto (Estudo Técnico Preliminar – ETP, e Documento de Formalização da Demanda – DFD).

(P) Produto 2.1.4 Reforma, adequação ou ampliação de 8 Unidades de Saúde Especializada

Este produto tem por objetivo a melhoria da infraestrutura física de oito Unidades de Saúde Especializadas, abrangendo serviços de saúde mental, reabilitação e atenção especializada em saúde bucal, com vistas à ampliação da capacidade instalada, à qualificação do cuidado e ao fortalecimento da rede de atenção especializada do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH).

No eixo da saúde mental, as intervenções contemplam: um Centro de Referência em Saúde Mental Infantojuvenil (CERSAMi), localizado na Regional Nordeste; dois Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), na Regional Barreiro e Pampulha; e um Centro de Referência em Saúde Mental Álcool e Drogas (CERSAM-AD), sendo um na Regional Barreiro.

O CERSAMi Nordeste é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas relacionadas à saúde mental na infância e adolescência, abrangendo transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de conduta, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), depressão, transtornos de ansiedade, psicoses, bem como situações relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas. O serviço referencia as Regionais Nordeste, Venda Nova e Norte, atendendo um contingente estimado de aproximadamente 300.000 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, residentes em territórios com índices de vulnerabilidade social entre elevado e muito elevado. Atualmente, a

unidade funciona em imóvel alugado, localizado no bairro Renascença, condição que limita a ampliação da oferta assistencial e a adequação plena da estrutura às diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Diante desse cenário, torna-se necessária a implantação de nova sede em terreno próprio, situado no bairro Nova Floresta, com área de 1.512,47 m², possibilitando, entre outros avanços, a ampliação dos leitos de Hospitalidade Noturna, a diversificação das atividades terapêuticas e a melhoria das condições de acolhimento e assistência integral. O custo estimado da obra é de R$16.000.000,00.

O CERSAM Barreiro é o serviço responsável pela retaguarda de atendimento psiquiátrico de urgência da Regional Barreiro, que possui população cadastrada/vinculada estimada em aproximadamente 292.400 usuários, distribuídos em 20 Centros de Saúde, com referência para 88 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Trata-se de uma regional com elevada densidade populacional, extensa área territorial e significativo grau de vulnerabilidade social, sendo que 34% de suas áreas apresentam índice de vulnerabilidade social classificado entre elevado e muito elevado. A unidade encontra-se instalada em imóvel próprio, com área total de 657,8 m², dispondo de recepção, seis consultórios, sala de oficinas terapêuticas, sala de plantão, sala de gerência, posto de enfermagem, dois banheiros para usuários, pátio, refeitório e duas enfermarias anexas. Embora caracterizada conforme as diretrizes de CAPS III, a estrutura física atual mostra-se insuficiente frente ao crescimento expressivo da demanda assistencial nos últimos anos. Desde maio de 2025, o CERSAM Barreiro figura como a unidade com maior volume de atendimentos em Hospitalidade Noturna no município, operando com 12 leitos, o que reforça a necessidade de intervenções de adequação e ampliação da infraestrutura. O custo estimado da obra é de R$16.000.000,00 que será realizada em terreno cedido a SMSA-BH de aproximadamente 1200m².

O CERSAM Pampulha é referência para o atendimento das crises em saúde mental da população residente na Regional Pampulha, que possui população estimada em aproximadamente 350 mil habitantes, sendo a regional mais populosa de Belo Horizonte. Com obras de ampliação da unidade espera-se a adequação da capacidade assistencial à demanda real do território, além de ampliação da capacidade de atendimento em situações de crise, com melhoria do acolhimento e da resolutividade clínica, expansão do número de leitos de Hospitalidade Noturna, redução das barreiras de acesso, qualificando o atendimento em um território de grande extensão. O custo estimado da obra é de R$16.000.000,00 e engloba ampliação e adequações em áreas de acolhimento e permanência dia, consultórios e salas para atendimentos individuais ou em grupo.

O CERSAM AD Barreiro é um serviço de urgência e emergência em saúde mental, de porta aberta, destinado ao atendimento de pessoas em sofrimento psíquico grave associado ao uso de álcool e outras drogas. O serviço atua como referência para as Regionais Barreiro e Oeste, atendendo uma população de referência estimada em 600.806 habitantes, número significativamente superior ao preconizado pela Portaria nº 3.088/2011, que estabelece como parâmetro para CAPS III uma população de até 200 mil habitantes. A construção de uma nova sede própria para o CERSAM AD Barreiro permitirá a adequação da estrutura física às necessidades assistenciais atuais e ao volume de demanda atendido, acompanhando os avanços obtidos com o incremento de profissionais e abertura de leitos emergenciais. O custo estimado da obra é de R$16.000.000,00, em terreno definido com 1800m².

Para as unidades de reabilitação pretende-se a obras de 3 unidades de Centros de Reabilitação (CREAB). A requalificação dos CREABs do Município de Belo Horizonte constitui ação estratégica para o fortalecimento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, ampliando o acesso, a resolutividade e a qualidade da atenção especializada em reabilitação física, auditiva, visual e intelectual. Além de atender às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a iniciativa busca garantir infraestruturas adequadas, acessíveis e tecnologicamente atualizadas, favorecendo a integralidade do cuidado e a articulação com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.

As 3 obras dos CREABs são direcionadas às regionais Leste, Centro-Sul e Norte. Para o CREAB Leste está prevista uma nova sede em terreno a ser definido dentro do território da regional, que garanta melhor acessibilidade física e viária aos usuários das regionais vinculadas. A atual estrutura apresenta limitações importantes, tanto em termos de localização quanto de espaço físico, o que compromete a ampliação da capacidade operacional e a oferta de novos serviços de reabilitação. A proposta de nova sede deve contemplar um projeto arquitetônico acessível e sustentável, com áreas de atendimento integradas e ambientes adequados para práticas multiprofissionais.

O CREAB Norte proposto terá perfil assistencial multiprofissional, contemplando áreas como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, dentre outros, conforme a necessidade dos usuários. O serviço será estruturado para atender prioritariamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em pessoas que apresentem impacto funcional conforme os critérios vigentes para as reabilitações oferecidas. estima-se uma cobertura assistencial na Regional Norte, ampliando a assistência aos usuários e reduzindo o tempo de espera por reabilitação especializada bem como o absenteísmo das famílias devido à dificuldade de deslocamento a outras regionais. A expectativa é também fortalecer a rede de atenção à saúde, promovendo maior articulação com a Atenção Primária, escolas e demais serviços socioassistenciais do território.

Já o CREAB Centro Sul está situado em área de locação com difícil acesso pelos usuários, em função da restrita malha viária destinada ao local, o que gera absenteísmo e baixa adesão ao tratamento oferecido, uma vez que os atendimentos são sistematizados levando a família a comparecer à unidade mais de uma vez por semana. A expectativa com as obras no novo espaço é de que haja ampliação dos atendimentos, uma vez que haverá espaço físico suficiente para o desenvolvimento de ações coletivas e para alocar profissionais novos para atendimento às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O custo estimado das obras para ampliação das três unidades é de R$18.000.000,00.

Para a unidade especializada em saúde bucal a necessidade é de adequação e ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas Venda Nova. A unidade é referência para o atendimento odontológico especializado no município, integrando a rede de Atenção Secundária em Saúde Bucal. As especialidades odontológicas ofertadas são: Endodontia, Periodontia, Odontopediatria, Cirurgia BMF, DTM, Ortodontia, PNE, Prótese e o serviço de radiologia odontológica. A reestruturação contempla a modernização tecnológica, a plena adequação às normas de acessibilidade e a qualificação dos ambientes de trabalho, promovendo maior segurança, resolutividade clínica e eficiência operacional. Situado em terreno próprio, a unidade precisa de adequações para acessibilidade e conformidade sanitária. O custo da obra está estimado em R$9.500.000,00.

(P) Produto 2.1.5 Reforma, adequação e ampliação de 3 Unidades de Vigilância

Este produto contempla intervenções em três unidades estratégicas de vigilância em saúde: o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Regional Norte, e dois Centros de Esterilização de Cães e Gatos, situados nas Regionais Leste e Venda Nova.

O Centro de Controle de Zoonoses é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, bem como pelo monitoramento das populações de animais, especialmente cães e gatos, com foco prioritário na Atenção Primária à Saúde (APS). A reforma tem como objetivo a melhoria das condições sanitárias, de alojamento e manejo dos animais, a modernização das instalações e a ampliação de setores técnicos e administrativos, incluindo áreas cirúrgicas, de eutanásia, educação em saúde e apoio aos trabalhadores, promovendo maior bem-estar animal e qualificação dos serviços prestados à população. O custo estimado da obra é de R$12.000.000,00, em terreno próprio do Município.

Os Centros de Esterilização de Cães e Gatos desempenham papel fundamental nas políticas públicas de controle populacional animal, por meio da realização de procedimentos cirúrgicos de esterilização associados a ações educativas voltadas à guarda responsável e à proteção da saúde pública. As intervenções previstas visam à adequação e ampliação da infraestrutura física, de modo a garantir melhores condições de acolhimento, segurança sanitária, conforto aos usuários e eficiência operacional, considerando o elevado volume anual de procedimentos realizados. O custo estimado para reforma, adequação e ampliação das duas unidades é de R$4.000.000,00.

(P) Produto 2.1.6 Reconstrução e adequação de 2 Unidades de Logística e Apoio a Assistência

O produto contempla a reforma e ampliação da sede da Gerência de Manutenção da SMSA (GEMAN/SMSA), localizada em terreno próprio do Município, no bairro União, com área aproximada de 17.376 m², visando adequar a infraestrutura física às atividades técnicas, operacionais e administrativas da unidade. A GEMAN exerce papel estratégico no suporte à rede municipal de saúde, sendo responsável pela manutenção predial preventiva e corretiva das unidades de funcionamento ininterrupto, além de desempenhar função logística de apoio ao Almoxarifado Central da Saúde e ao armazenamento de materiais, insumos e equipamentos essenciais à continuidade da assistência.

Adicionalmente, o produto prevê a ampliação e adequação da sede do Almoxarifado Central da Saúde, localizada na região Oeste, responsável pelo armazenamento e distribuição de insumos, materiais e equipamentos para todas as unidades assistenciais do município. As intervenções visam evitar restrições operacionais por limitação de espaço físico e assegurar o funcionamento contínuo da rede de saúde. O investimento total estimado para as duas unidades é de R$16.000.000,00.

(S) SUBCOMPONENTE 02 - Aparelhar as unidades da Rede Especializada e de Urgência

(P) Produto 2.2.1 Aquisição de equipamentos para 16 Unidades de Saúde

O produto prevê a aquisição e atualização de equipamentos clínico-assistenciais para todas as unidades contempladas no Subcomponente 01, incluindo equipamentos de alta complexidade, mobiliários e equipamentos de apoio, para garantir a adequação funcional aos diferentes serviços da rede de atenção à saúde. Adicionalmente, contempla a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, essenciais à digitalização da gestão e da assistência, à integração com os sistemas de informação e ao fortalecimento da capacidade operacional das unidades. Valor estimado de R$45.117.000,00.

(P) Produto 2.2.2 Aquisição de equipamentos para 2 Unidades de Logística e Apoio a Assistência

O produto contempla a aquisição de equipamentos destinados à manutenção predial e à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos clínico-assistenciais, assegurando a continuidade operacional da rede de saúde e a conformidade com as normas técnicas e sanitárias. Adicionalmente, prevê equipamentos para armazenamento, controle, movimentação e distribuição de materiais e insumos,visando o fortalecimento da cadeia logística, à otimização dos fluxos de suprimento e à melhoria da eficiência e continuidade dos serviços prestados à população.O valor estimado para equipar todas as unidades de apoio é de R$4.000.000,00.

1. 5. 15. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 3 - Modernização, ampliação e qualificação do cuidado e gestão em saúde
Valor estimado em Real (BRL): 54.301.000,00

Descrição:
O componente 3 possui o desafio de integrar os sistemas de informação e melhorar a gestão de fluxos de trabalho. Ele está pautado na Transformação Digital e Telessaúde na Rede SUS-BH e na Modernização da Educação Permanente em Saúde e dos Serviços de Gestão, com a aquisição de equipamentos médicos, modelagem para novos serviços de saúde digital, implantação de Centro de Custos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH), aparelhamento da Central do Telessaúde SUS-BH, com estrutura de conectividade e mobília, desenvolvimento e implantação de modelos preditivos na saúde, de sistema inteligente de gestão de filas, de monitoramento e controle de zoonoses e de espaço formativo digital. Além disso, haverá a gestão de informação de prontuários médicos físicos, a construção e aparelhamento de um laboratório de habilidades e simulação realística e a realização de seminários anuais de Educação Permanente em Saúde. Os resultados almejados incluem a melhoria da longitudinalidade e da integralidade do cuidado, a otimização dos fluxos de trabalho para reduzir a burocracia, a ampliação do acesso da população a especialistas por meio do atendimento remoto (Telessaúde) e, consequentemente, a redução de deslocamentos desnecessários, a alocação mais eficiente dos recursos e a qualificação da gestão e assistência prestada.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S) SUBCOMPONENTE 01 - Transformação Digital e Telessaúde na rede SUS-BH

Este subcomponente atua de forma multinível e contempla diferentes níveis de atenção da rede SUS-BH, com entregas que integram a Atenção Primária (coordenadora do cuidado) e a Atenção Secundária/Especializada (consultas com especialistas e telediagnóstico).

(P) Produto 3.1.1 Aquisição de equipamentos para a Central do Telessaúde SUS-BH

Levando em conta que o serviço de telessaúde já ocorre no município e necessita ser fortalecido, ampliado para atender à crescente demanda por assistência diagnóstica e clínica, especialmente para especialidades de alta prevalência como cardiologia, dermatologia e angiologia, e incorporar novas funcionalidades, a Central de Telessaúde SUS-BH requer adequação de espaços físicos, aquisição de novos equipamentos e infraestrutura de conectividade para fortalecimento das modalidades de teleconsulta, teleconsultoria, telemonitoramento e telediagnóstico. Dessa forma, este produto possui um custo previsto de R$8.000.000,00 que engloba a aquisição de equipamentos de tecnologia e mobiliário ajustados à demanda de atendimentos da central.

(P) Produto 3.1.2 Modelagem para novos serviços de saúde digital no SUS-BH

A modelagem prevista no Produto 3.1.2 funciona como base estruturante para o desenvolvimento e a implantação das soluções tecnológicas que compõem o Componente 03 do Programa e contempla os níveis da Atenção Primária e Especializada da rede SUS-BH. Ela define como os processos de trabalho serão reorganizados para que as ferramentas digitais a serem adotadas gerem valor assistencial e operacional e operem de forma integrada e eficiente. Ao custo total previsto de R$500.000,00, a modelagem garantirá a sustentabilidade dos fluxos implementados e dos benefícios oriundos e servirá de guia para os produtos do Subcomponente 02: modelos preditivos, gestão inteligente de filas, monitoramento e controle de zoonoses, gestão de prontuários médicos físicos e Centro de Custos da Secretaria Municipal de Saúde.

(P) Produto 3.1.3 Aquisição de equipamentos médicos especializados para saúde digital na rede SUS-BH

Com custo estimado de R$4.301.000,00 e cronograma de pagamentos para o segundo e terceiro ano do Programa, o produto prevê a aquisição de equipamentos de telediagnóstico que incluem ultrassom portátil, retinógrafo portátil,

espirômetro digital, dermatoscópio digital, doppler vascular portátil e eletroencefalograma digital (EEG), assim como outros que se fizerem relevantes para a ampliação dos serviços, ampliando a capacidade diagnóstica e realizando a interface entre a Atenção Primária e a Especializada, permitindo exames especializados de forma otimizada.

(S) SUBCOMPONENTE 02 - Modernização dos serviços de gestão em saúde

O Subcomponente 02 abrange iniciativas de gestão e inteligência que apoiam a regulação e o monitoramento nos níveis da saúde, contribuindo para o aprimoramento da Atenção Primária e da Atenção Especializada.

(P) Produto 3.2.1 Desenvolvimento e implantação de modelos preditivos no SUS-BH

Com um investimento previsto de R$4.000.000,00, este produto consiste no desenvolvimento e na implementação de algoritmos de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning customizados para a realidade epidemiológica e operacional de Belo Horizonte. O objetivo não é apenas coletar dados, mas transformá-los em capacidade preditiva, permitindo que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) antecipe cenários em vez de apenas reagir a eles, o que contribuirá para os demais produtos do Subcomponente 02 na geração de dados robustos, na infraestrutura de processamento e integração com o e-SUS e SIGRAH e na garantia de uma ferramenta que reduz o desperdício público (devido ao absenteísmo e surtos não controlados).

(P) Produto 3.2.2 Desenvolvimento e implantação de sistema inteligente de gestão de filas no SUS-BH

O sistema inteligente de gestão de filas unifica a inteligência preditiva à operação de campo, possibilitando eficiência no acesso a serviços especializados. Com o maior investimento do componente 03, totalizando R$13.000.000,00, o produto engloba o desenvolvimento do modelo, a interface para o usuário, consultoria especializada e infraestrutura de dados globais (Google para mapeamento geográfico e clima-tempo), além da automatização da comunicação ativa. O sistema exige integração nativa com a Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de Regulação (SIGRAH) (já implementada na SMSA PBH) para o cruzamento de dados de usuários e execução de marcações automáticas otimizadas e, abrangendo todas as unidades de saúde do SUS-BH, atuará na identificação de perfis; mapeamento de pacientes e situações (clima, sazonalidade, regionalização) com alta probabilidade de absenteísmo; ajuste da capacidade operacional e otimização de agendas em tempo real; automatização do contato com o paciente para confirmação de procedimentos.

Com isso, espera-se uma redução direta de custos gerados pela ociosidade (faltas) e diminuição indireta de gastos com o agravamento de quadros clínicos por demora no atendimento, a ampliação da produção assistencial cofinanciada da rede SMSA-BH devido à maior eficiência dos agendamentos e garantia de acesso universal e otimização dos recursos humanos, liberando as equipes de regulação de tarefas manuais para atividades estratégicas.

(P) Produto 3.2.3 Desenvolvimento e implantação de sistema de Monitoramento e Controle de Zoonoses

Para otimizar a capacidade de resposta diante da caracterização de risco entomológico e epidemiológico, o produto propõe o desenvolvimento e a implantação de um sistema de Monitoramento e Controle de Zoonoses. Esse sistema fortalecerá a agilidade das intervenções, aprimorará a comunicação, ampliará o compartilhamento de informações para a tomada de decisões, qualificará a definição e o acompanhamento de indicadores de produção e qualidade e permitirá avaliações mais refinadas. O sistema deverá contar com módulos de atividades relativos aos programas de controle de leishmaniose visceral, arboviroses, esporotricose, raiva, fauna sinantrópica, módulo laboratorial para zoonoses, manejo populacional de cães e gatos e Centro de Controle de Zoonoses.

A maioria dos pontos de função já foram definidos com a área técnica de Tecnologia da Informação da SMSA e com a PRODABEL (empresa de economia mista de Informática e Informação do município de Belo Horizonte), restando apenas os módulos de manejo da população de animais e Centro de Controle de Zoonoses para serem definidos em termos de pontos de função.

É desejável que este sistema tenha integração com os sistemas de Vigilância Estadual e Nacional, pois a solução servirá de base para resposta oficial aos diversos indicadores como o PNCD, PCLV, PCDCH. As bases de dados geradas poderão ser trabalhadas através de painéis parametrizáveis para extração ágil e intuitiva de informações sobre a produção de campo, contribuindo ainda para a apuração de indicadores ligados ao Plano Municipal de Saúde (PMS) e aos relatórios de desempenho quadrimestral e anual de gestão (RDQA e RAG), bem como aqueles relacionados à apuração da bonificação por cumprimento de metas resultados e indicadores (BCMRI). O desenvolvimento e implantação desse sistema possui um custo total previsto de R$4.500.000,00.

(P) Produto 3.2.4 Implantação do Centro de Custos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte

O Produto 3.2.4 possui um prazo estimado de execução de 18 meses e valor de R$2.000.000,00 com o intuito de custear a contratação de consultoria especializada para o apoio técnico e operacional e customizações em sistemas

já adotados na prefeitura que resultem na elaboração e implantação do Centro de Custos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH). Diferente de outras soluções do programa, este produto não prevê a aquisição ou desenvolvimento de novos softwares. A consultoria terá a missão de integrar dados de RH, Contratos e Compras, transformando informações fragmentadas em relatórios gerenciais que permitam a visualização precisa da despesa por programa, projeto e unidade administrativa e busca solucionar a ausência de um mapeamento atualizado dos processos de custeio e fluxos de informação. A implantação do Centro de Custos é justificada pela necessidade de prover uma visão detalhada da alocação de recursos públicos, subsidiar gestores com dados reais para otimização do orçamento e ampliar a responsabilidade compartilhada entre as diversas áreas da SMSA-BH. A implantação do Centro de Custos trará maior eficiência no uso dos recursos, identificação de gargalos e oportunidades de economia, melhoria na capacidade de realizar projeções financeiras baseadas em dados históricos sólidos e fortalecimento da prestação de contas e da responsabilidade fiscal da Secretaria frente aos órgãos de controle. Este produto complementa o ecossistema digital do Programa, garantindo que a modernização dos serviços de gestão em saúde seja acompanhada por um rigoroso controle financeiro e sustentabilidade orçamentária.

(P) Produto 3.2.5 Gestão de informação de prontuários médicos físicos

Está previsto um custo total de R$8.000.000,00, a partir do segundo ano do Programa, para contratação de serviços de: (i) digitalização: preparação, higienização, organização, digitalização, tratamento de imagens e indexação, (ii) sistema de gestão de documentos, que atenda a todos os requisitos arquivísticos previstos na legislação vigente e (iii) repositório digital, confiável e que permita a manutenção / preservação dos documentos digitais desde sua captura pelo sistema informatizado de gestão, pelo tempo previsto na tabela de temporalidade abrangendo o histórico do paciente, garantindo a continuidade do cuidado e a disponibilidade de dados em toda a rede assistencial. Como benefício, espera-se obter uma redução do consumo de papel e de geração de resíduos e melhoria no atendimento ao cidadão: com o tempo do profissional otimizado (sem busca por papel), ele pode dedicar mais atenção e tempo ao paciente, melhorando a experiência e a humanização do cuidado. Para além disso, haverá o benefício do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), proteção contra perdas e extravios de documentos, controle de acesso, eficiência operacional e redução de custos.

(S) SUBCOMPONENTE 03 - Modernização e Fortalecimento da Educação Permanente em Saúde na rede SUS-BH

O Subcomponente 03 destina-se à qualificação de profissionais que atuam em diferentes pontos de atenção da rede, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária e da Atenção Especializada.

(P) Produto 3.3.1 Desenvolvimento e implantação de espaço formativo digital na rede SUS-BH

Há previsão de R$2.500.000,00 para este produto, destinado ao financiamento de ações voltadas ao levantamento de perfis, competências e necessidades formativas dos trabalhadores da rede SUS-BH. Essas ações subsidiarão a proposição de um ambiente formativo digital, nos moldes de uma plataforma LMS (Learning Management System), para a criação de “trilhas de conhecimento” personalizadas, com conteúdos adaptados por território, regional e perfis profissionais, bem como de um “espaço do saber” interativo e virtual, voltado ao compartilhamento de experiências, materiais pedagógicos e boas práticas, estimulando o diálogo e a aprendizagem coletiva.

Com isso, almeja-se promover capacitação permanente e equitativa, respeitando a diversidade de perfis, competências e necessidades formativas identificadas, além de fomentar uma aprendizagem prática e aplicável ao contexto de cada unidade e território de saúde da PBH, um planejamento formativo mais assertivo e estratégico, o fortalecimento do cuidado e a consequente melhoria dos serviços de saúde. Para a consolidação do produto, propõe-se a contratação de facilitadores para a realização de oficinas, a implantação de um estúdio audiovisual para produção e edição de videoaulas e materiais didáticos complementares para as “trilhas de conhecimento”, bem como a contratação de consultoria técnica para diagnóstico e levantamento de dados, devendo o espaço formativo possibilitar o monitoramento e a avaliação de indicadores de desempenho e impacto das capacitações.

(P) Produto 3.3.2 Construção 01 Laboratório de Habilidades e Simulação Realística (LabSim)

O laboratório de Habilidades e Simulação Realística (LabSim) irá complementar o desenvolvimento e implantação do espaço formativo (produto 3.3.1) permitindo que os trabalhadores da rede SUS-BH pratiquem situações clínicas e de gestão de forma segura, desenvolvendo competências técnicas, comunicacionais e de trabalho em equipe, aplicando os conhecimentos adquiridos nas trilhas de aprendizagem e replicando nas rotinas de trabalho. Estão previstos R$1.000.000,00 para custeio do produto no segundo e terceiro ano do programa.

(P) Produto 3.3.3 Equipar 01 Laboratório de Habilidades e Simulação Realística (LabSim)

Há um custo previsto de R$5.500.000,00 para aquisição de manequins de alta tecnologia e sinais vitais realísticos, equipamentos e mobília para o Laboratório de Habilidades e Simulação Realística (LabSim). Com isso, vislumbra-se a criação de um ambiente para simulações clínicas e de gestão, que integre teoria e prática, e, possibilite aos trabalhadores da rede SUS-BH desenvolver competências técnicas e gerenciais para adoção na assistência

prestada.

(P) Produto 3.3.4 Seminários anuais de Educação em Saúde na rede SUS-BH

Com o intuito de criar um espaço de troca entre trabalhadores, gestores, instituições de ensino e parceiros, validar as trilhas de conhecimento desenvolvidas, identificar lacunas e promover melhorias no espaço formativo, estão definidos R$1.000.000,00 para realização anual de seminário de educação em Saúde na rede SUS-BH. Dessa forma, há previsão de realização de 05 seminários, no valor unitário de R$200.000,00 cada, devendo incluir locação de espaço, material didático, equipe de logística, palestrantes/facilitadores e custos com divulgação.

1. 5. 16. **Informações do 4° componente:**
Nome: Componente 4 - Gestão do Programa
Valor estimado em Real (BRL): 32.387.000,00

Descrição:
O desafio administrativo fundamental é a necessidade de uma governança estruturada e especializada para gerenciar a complexidade de um projeto de crédito externo com múltiplos eixos de investimento, garantindo a conformidade com as regras do órgão fiduciário. Dessa forma, o quarto componente do Programa se baseia no fortalecimento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), que será responsável pelo planejamento operacional, gestão de aquisições, monitoramento de indicadores e compliance financeiro, para que a execução física e financeira seja eficiente, transparente e condizente com o planejado e, busca assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais, a mitigação de riscos e a otimização dos impactos alcançados pelos demais componentes do projeto, por meio da realização de auditoria externa, da supervisão técnica, ambiental e social das obras e da avaliação do impacto do Programa com ações de comunicação e divulgação.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P) Produto 4.1 - Constituição da Unidade de Gerenciamento do Programa

Em cumprimento à cláusula contratual, a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) será composta por especialistas consultores para as Coordenações Financeiras, de Aquisições, Monitoramento, economista/analista financeiro com experiência em PPPs e Supervisão Executiva, além de consultores especialistas em obras, ESG e outras demandas pertinentes ao monitoramento e execução do programa. A UGP começará suas atividades concomitante ao início de execução do Projeto, com valor estimado total de custeio de R$24.408.000,00.

(P) Produto 4.2 - Auditoria Externa

A auditoria externa poderá ser realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) mediante acordo de Cooperação Técnica ou por meio de empresa consultora contratada. Sendo cláusula contratual e requisito para o mutuário incorrer nos desembolsos, há R$500.000,00 planejados para custeio anual ao longo do prazo de execução do Programa.

(P) Produto 4.3 - Avaliação de Impacto do Programa

Considerando que se trata de um Programa de desenvolvimento social, é essencial mensurarmos os impactos gerados. Dessa forma, será contratada empresa de consultoria que realizará a avaliação do Programa conforme metodologia definida pelo financiador, no valor previsto total de R$1.000.000,00.

(P) Produto 4.4 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social das obras

Com o intuito de assegurar a conformidade técnica e a mitigação de riscos nos empreendimentos de estruturação física, será contratada uma empresa gerenciadora de suporte técnico à fiscalização para prestar apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). Esta contratação justifica-se pela necessidade de um acompanhamento especializado e contínuo que garanta que as obras de infraestrutura estarão cumprindo integralmente os projetos executivos e os cronogramas previstos.

Além disso, a empresa contratada atuará diretamente na fiscalização de campo e no suporte consultivo, validando medições de campo, realizando controle de qualidade dos materiais aplicados, garantindo a execução conforme os padrões de engenharia, monitorando o cumprimento das condicionantes ambientais, fiscalizando a gestão de resíduos, acompanhando ações mitigadoras de impactos junto às comunidades locais, elaborando relatórios mensais de progresso, fazendo análises técnicas de diários de obra e fornecendo subsídios para a aprovação de medições e

pagamentos por parte da UGP. Dessa forma, a atuação da empresa de apoio visa fortalecer a capacidade de gestão da UGP, garantir a eficiência na aplicação dos recursos e a entrega dos ativos de infraestrutura dentro das normas vigentes do BID. Para tanto, o investimento previsto para a prestação deste serviço é de R$4.100.000,00.

(P) Produto 4.5 - Custos Gerais (SAFF, Obras Gov, MS Project, Capacitações equipe de projetos)

Para este produto há previsão total de R$1.500.000,00 com dispêndios a partir do início da execução do Projeto uma vez que, objetiva capacitações em projetos de desenvolvimento para a UGP, contratação de Sistemas e Softwares de gestão financeira, física e de monitoramento do projeto, além de ferramentas e sistemas de acompanhamento de projetos e obras.

(P) Produto 4.6 - Comunicação e mídias de divulgação do Programa (Eventos, Hotsite, Vídeo-documentário)

Com um orçamento previsto de R$879.000,00, este produto visa assegurar a transparência, engajar as partes interessadas e divulgar os objetivos esperados e alcançados para a população beneficiada e para os Órgão financiadores. Dessa forma, pretende-se a realização de eventos relacionados à execução dos demais produtos, o desenvolvimento de plataforma digital para compilar em um único espaço virtual específico as principais informações do Programa e a realização de um vídeo-documentário a ser exibido nas unidades de saúde e nos meios de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) dando visibilidade aos feitos e resultados obtidos com o Programa. O produto visa ainda o custeio de estruturas de eventos e placas para inaugurações, backdrop e telões para coletivas, placas com logo da PBH para fachada das obras do Programa e faixas de rua com orientações de mudança de endereço.

1. 6. **Beneficiários**

Os beneficiários do Programa Melhor Saúde BH II abrangem grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade social e sanitária, bem como usuários frequentes do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte, trabalhadores da rede SUS-BH e, de forma indireta, toda a população do município, em função do fortalecimento da capacidade assistencial, da vigilância em saúde e da resposta a emergências.

A definição dos beneficiários está diretamente associada às desigualdades socioeconômicas e territoriais existentes no município, ao perfil demográfico marcado pelo envelhecimento populacional e à elevada dependência do SUS, especialmente nas regiões com maior vulnerabilidade social.

População em situação de pobreza e em situação de rua

Entre os principais beneficiários diretos do programa estão as pessoas em situação de pobreza e em situação de rua. Estima-se que Belo Horizonte possua 14.454 pessoas em situação de rua em 2025 e 92.622 pessoas em situação de pobreza, segundo dados oficiais recentes. Esses grupos apresentam condições socioeconômicas caracterizadas por renda insuficiente, baixa escolaridade, moradia precária ou inexistente e vínculos frágeis com redes de proteção social.

Essas condições resultam em maior exposição a riscos ambientais e sanitários, insegurança alimentar, dificuldade de acesso à água potável e saneamento e limitações para o autocuidado. Como consequência, observa-se maior incidência de doenças infecciosas e parasitárias, agravos nutricionais, doenças crônicas não transmissíveis, problemas de saúde bucal, demandas em saúde da mulher e sofrimento mental associado à violência, estresse e discriminação. O programa endereça essas carências principalmente por meio da ampliação e qualificação da Atenção Primária à Saúde e do fortalecimento das redes especializadas, reduzindo barreiras de acesso e prevenindo agravamentos que pressionam os serviços de urgência e emergência.

Pessoas idosas

Outro grupo prioritário é o das pessoas idosas, que representam cerca de um quinto da população do município, totalizando aproximadamente 460 mil habitantes com 60 anos ou mais. O envelhecimento populacional em Belo Horizonte é acompanhado por fortes desigualdades socioeconômicas entre regiões administrativas, refletidas em diferenças nos níveis de escolaridade, renda e acesso a planos de saúde.

Em três das nove regionais administrativas, cerca de 40% dos domicílios com pelo menos um idoso possuem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo, enquanto na região Centro-Sul esse percentual é significativamente menor. Ademais, 66,2% dos idosos não possuem plano de saúde, o que evidencia elevada dependência do SUS. As principais carências desse grupo relacionam-se ao manejo da multimorbidade, polifarmácia, prevenção de quedas, limitações funcionais, controle de doenças crônicas, saúde bucal e atenção à saúde mental e ao isolamento social. O fortalecimento da APS, aliado à ampliação da rede de reabilitação, saúde mental e especialidades, é central para responder a essas demandas de forma contínua e integrada.

Pessoas com doenças crônicas, gestantes, crianças e adolescentes

Grupos populacionais que demandam acompanhamento longitudinal também figuram entre os beneficiários diretos do programa. Estima-se que cerca de um quarto da população de Belo Horizonte conviva com doenças crônicas, o que requer cuidado contínuo, coordenação entre níveis de atenção e ações preventivas para evitar complicações. Somam-se a esse grupo aproximadamente 22.000 gestantes e cerca de 236.347 crianças de 0 a 9 anos, além de adolescentes que demandam ações específicas de promoção, prevenção e cuidado integral.

A ampliação da capacidade da Atenção Primária, associada ao fortalecimento das redes especializadas, incluindo saúde mental infantojuvenil, contribui para melhorar desfechos em saúde materno-infantil, reduzir internações evitáveis e promover desenvolvimento saudável na infância e adolescência.

Trabalhadores da rede

Os trabalhadores da rede SUS-BH (em torno de 20.000 pessoas) também constituem beneficiários relevantes do programa. As ações de educação permanente, capacitação e inovação pedagógica respondem à necessidade de atualização contínua de competências, padronização de práticas e fortalecimento da capacidade de resposta institucional, com impactos diretos na qualidade da assistência prestada.

Usuários do SUS-BH e benefícios coletivos e proteção à população em geral

A população de Belo Horizonte é beneficiada de forma indireta pelo fortalecimento da vigilância em saúde e pelos investimentos em unidades de controle de zoonoses e de urgência e emergência. A vigilância em saúde atua como mecanismo de proteção coletiva, prevenindo e controlando agravos como leishmaniose, raiva, esporotricose, entre outros riscos sanitários que impactam o território como um todo. De modo complementar, a ampliação e a modernização das unidades de urgência e emergência asseguram respostas mais rápidas e resolutivas em situações críticas, contribuindo para a redução de óbitos evitáveis e dos impactos sociais decorrentes de eventos agudos em saúde.

De forma transversal, todos os usuários do SUS-BH são beneficiados pelas ações de modernização, ampliação e qualificação do cuidado e da gestão em saúde. A incorporação de soluções digitais, a reorganização de processos, o uso mais racional dos recursos e a ampliação da Telessaúde fortalecem o vínculo entre usuários e serviços, reduzem deslocamentos desnecessários e aumentam a resolutividade do sistema. Considerando o princípio da universalidade do SUS, entende-se que toda a população belorizontina é potencialmente beneficiária dessas ações. Ademais, por Belo Horizonte ser sede da Macrorregião de Saúde de Minas Gerais, os benefícios extrapolam os limites municipais, alcançando um contingente populacional superior aos 2,4 milhões de habitantes do município.

1. 7. **Anexos**

Cartilha Orientadora PPP

Carta de anuência BID

Tabela de indicadores

Tabela de indicadores atualizada após a reunião com a equipe da Cofiex do dia 29/01/2026.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa Melhor Saúde BH II está integralmente alinhado às prioridades do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, com destaque para a Área Estratégica IV - Saúde: atenção primária e especializada, conforme o §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024. Destacam-se os Objetivos Estratégicos do PPA relacionados ao Programa:

101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social.

As equipes de saúde mapeiam e identificam vulnerabilidades e riscos sociais (incluindo insegurança alimentar e pobreza), realizam ações de educação em saúde e vigilância nutricional, e monitoram o estado nutricional de grupos prioritários, como crianças, gestantes e idosos. As populações em condição de vulnerabilidade social são aquelas que estão, em maior número, nos domicílios com identificação de insegurança alimentar. Essas ações integradas fortalecem a prevenção e qualificam o cuidado no território.

A Atenção Primária à Saúde (APS), por meio das Equipes de Saúde da Família, desempenha papel central na redução das Internações por Condições Sensíveis à APS (ICSAP), como gastroenterites, desnutrição, carências nutricionais e anemias. Além disso, na APS - ordenadora do cuidado, são realizados atendimentos e ações de promoção com foco na prevenção, controle e tratamento das diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, incluindo o manejo adequado destas condições durante a gestação, condições que aumentam o risco para mortalidade prematura.

102 Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade requer o fortalecimento integrado do SUS. A modernização das unidades básicas e a requalificação da rede especializada e das urgências e emergências ampliam a capacidade resolutiva, melhoram fluxos assistenciais e garantem acolhimento e cuidado efetivo no território. A capacitação contínua dos profissionais e a modernização dos sistemas de informação, aliadas à melhoria da comunicação institucional, qualificam práticas assistenciais, fortalecem a integração entre serviços e aprimoram a transparência e o diálogo com a população, somam-se a isso os investimentos na infraestrutura de vigilância, que ampliam a prevenção, o monitoramento e a resposta a riscos sanitários.

Conjuntamente, essas ações estruturais, tecnológicas e organizacionais tornam o SUS mais eficiente, equitativo e capaz de oferecer serviços de qualidade, contribuindo diretamente para ampliar o acesso da população à saúde pública.

106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões.

A oferta de atendimentos na APS contribui efetivamente para a derrubada de barreiras de acesso ao cuidado à população, especialmente pertencentes aos grupos de vulnerabilidade social. Os serviços de saúde mental atuam no tratamento de danos emocionais e transtornos e sofrimentos psíquicos, que para além da clínica médica, fornecem ao usuário orientação e clareza no reconhecimento dos abusos e no afastamento dos agressores como forma de reduzir os números das diversas formas de violência, injustiças e opressões. Ademais, os serviços ofertados pelos Centros de Reabilitação fortalecem a qualidade e acesso à integralidade do cuidado, atuando no combate aos estigmas e discriminações relacionados à deficiência, promovendo autonomia e reabilitação funcional. Os cuidados integrais promovem, além da assistência em saúde, a inclusão social, a proteção de pessoas e a equidade de direitos.

107. Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência.

O projeto está alinhado às Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher do SUS, que asseguram cuidado contínuo e humanizado em todos os ciclos de vida, com ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. No SUS BH, essa atenção é ofertada, inicialmente, pelas Equipes de Saúde da Família e de Apoio, nos Centros de Saúde (porta de entrada da rede) por meio de atendimentos individuais e coletivos e, quando necessário, as mulheres são encaminhadas para serviços especializados. Além disso, Belo Horizonte conta com o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), referência regional no atendimento às vítimas de violência sexual, oferecendo cuidado emergencial e ambulatorial com equipe multiprofissional e abordagem humanizada.

A construção, reforma e aparelhamento das unidades de saúde, somados aos investimentos em telessaúde e às melhorias na gestão estratégica e nos processos assistenciais, ampliarão a capacidade instalada e qualificarão a oferta de serviços voltados às mulheres, fortalecendo a integralidade do cuidado e a equidade em saúde.

111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O Programa Melhor Saúde BH II contribui para a construção de cidades mais criativas e sustentáveis ao investir na implantação e qualificação de equipamentos sociais de saúde com diretrizes infraestruturais sustentáveis. As unidades incorporam princípios de sustentabilidade, arquitetura bioclimática e eficiência energética, promovendo edificações mais resilientes e adequadas ao contexto urbano e climático.

Os empreendimentos também observam a legislação ambiental vigente e os parâmetros urbanísticos e de uso e ocupação do solo definidos no Plano Diretor de Belo Horizonte, assegurando a integração dos equipamentos à dinâmica urbana e a minimização de impactos ambientais. Dessa forma, o programa qualifica a infraestrutura pública de saúde e contribui para o desenvolvimento urbano sustentável do município.

202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

A construção das unidades de APS amplia a presença territorial e fortalece ações preventivas, vigilância em saúde e identificação precoce de agravos relacionados a eventos climáticos, além de apoiar o acompanhamento de populações vulneráveis durante ondas de calor, enchentes e surtos epidemiológicos. Ademais, a construção e o aparelhamento das unidades de urgência e especializadas ampliam a capacidade de resposta rápida a desastres, garantindo atendimento seguro e resolutivo a vítimas de eventos extremos e emergências sanitárias, com estruturas mais resistentes, preparadas e integradas à rede. Por fim, o fortalecimento dos sistemas de zoonoses melhora a detecção, monitoramento e controle de agravos potencializados pelas mudanças climáticas, contribuindo para reduzir riscos ambientais e sanitários e proteger a população de forma contínua.

206 Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado-institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

O projeto promove o avanço da ciência, tecnologia e inovação ao modernizar a infraestrutura digital, ampliar o uso de dados e incorporar soluções inteligentes na gestão e na assistência à saúde. A criação de ambientes voltados à formação qualificada, à simulação realística e ao desenvolvimento de tecnologias aplicadas favorece a aproximação com instituições de pesquisa e estimula a inovação dentro da rede SUS-BH. Além disso, a execução do projeto envolve cooperação direta entre o município, a União e o BID, fortalecendo a articulação Estado–institutos de pesquisa–empresas e ampliando a capacidade de incorporar tecnologias avançadas para enfrentar desafios complexos da saúde pública. Dessa forma, consolida-se um contexto de inovação mais robusto, colaborativo e orientado por evidências, ampliando a capacidade institucional de desenvolver, testar e implementar soluções tecnológicas de alto impacto.

302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

O projeto fortalece as capacidades estatais ao promover a modernização da infraestrutura física, tecnológica e gerencial da rede municipal de saúde, elevando a eficiência institucional e aprimorando a qualidade dos serviços prestados à população. A incorporação de soluções digitais, a revisão e qualificação de processos administrativos e assistenciais e o investimento contínuo na formação e no desenvolvimento dos trabalhadores ampliam a capacidade do poder público de ofertar serviços mais resolutivos, integrados e aderentes às necessidades reais dos usuários. Além disso, a cooperação estabelecida entre o Município de Belo Horizonte e a União para viabilizar investimentos estratégicos reforça a articulação federativa e contribui para maior coesão nacional, ao mobilizar esforços compartilhados para fortalecer a inovação, a gestão e a capacidade de prestação de serviços no âmbito do SUS.

303 Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

A ampliação dos serviços digitais no SUS-BH, associada à qualificação da telessaúde, aumenta a agilidade do atendimento, amplia o acesso e permite respostas mais rápidas e integradas às necessidades da população. A adoção de ferramentas de análise preditiva, sistemas inteligentes de gerenciamento de demandas e sistemas de monitoramento fortalece a capacidade do governo local de tomar decisões baseadas em evidências, reduzir filas, otimizar recursos e antecipar riscos sanitários. Da mesma forma, a modernização dos processos de gestão administrativa e assistencial (incluindo a digitalização de informações, a adoção de novos modelos de organização e o fortalecimento da governança) amplia a eficiência operacional e a capacidade de entrega de resultados. Paralelamente, o investimento em ambientes digitais de formação, simulação e qualificação profissional potencializa a cultura de inovação no serviço público e fortalece a capacidade de adaptação dos trabalhadores às novas tecnologias. Dessa forma, o projeto gera um salto qualitativo na transformação digital da saúde municipal, alinhado às diretrizes nacionais

para ampliar a agilidade, a integração e a efetividade das políticas públicas nos três níveis de governo.

2. 2. **Anexos**

Áreas estratégicas PPAGOV

Áreas estratégicas PPAGOV ajustada após reunião com a Cofiex em 29/01/2026

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do Programa envolve a participação de diversas instituições, cada uma desempenhando um papel fundamental para garantir a execução eficiente e coordenada das ações previstas. A governança do programa será baseada em um modelo de gestão integrada, com responsabilidades definidas para cada instituição envolvida.

Instituições envolvidas e seus papéis:

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): instituição responsável pelo financiamento das ações do programa. Acompanha e avalia a implementação das metas e compromissos assumidos no contrato de financiamento.

Prefeitura do Município de Belo Horizonte (PBH): instituição proponente do financiamento e garantidora da execução do programa. Responsável por fornecer suporte institucional e normativo para a implementação do programa.

Secretaria Municipal de Saúde (SMSA): órgão executor do programa, responsável pela coordenação geral, planejamento estratégico, monitoramento da execução física e financeira, acompanhamento contratual de fornecedores e concessionárias quando aplicável.

Unidade de Gestão de Projeto (UGP): responsável pelo gerenciamento técnico e administrativo das ações, acompanhamento dos cronogramas e indicadores, bem como pela prestação de contas e elaboração de relatórios periódicos. Além disso, será responsável por garantir a articulação entre as diferentes instituições envolvidas, promovendo maior eficiência e transparência na execução do programa.

Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA): responsável por receber os depósitos oriundos dos desembolsos do contrato de empréstimo do BID e por transferir os recursos à conta corrente específica da SMSA vinculada ao projeto. Além disso, será responsável por disponibilizar os recursos de contrapartida do Tesouro Municipal, de acordo com o planejamento financeiro de execução.

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI): órgão responsável pela coordenação, planejamento e supervisão das intervenções de infraestrutura previstas no Programa, bem como pelo alinhamento institucional com os demais órgãos envolvidos.

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP): a Sudecap, ou outro órgão que vier a sucedê-la com atribuições similares, será responsável por licitar e contratar os projetos executivos e as obras nos termos da legislação municipal vigente. A SUDECAP também terá um papel fundamental no acompanhamento e fiscalização das obras de edificações a serem desenvolvidas sob o regime de Parceria Público-Privada (PPP), garantindo a aderência aos padrões técnicos e normativos.

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG): participará do Programa por meio de uma de suas subordinadas, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUPLOR) e por meio da PRODABEL, que é vinculada à SMPOG.

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUPLOR): responsável por organizar, em articulação com outros órgãos da administração municipal, a captação de recursos junto aos órgãos e instituições nacionais e internacionais e monitorar sua aplicação. A DCFI/SUPLOR atuará como representante do Município no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM), inserindo dados e documentos necessários para obtenção da autorização da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para contratação da operação de crédito junto ao BID.

Subsecretaria de Planejamento Estratégico e Tecnologia em Saúde (SUPTEC): responsável por englobar as equipes gestoras da UGP, da PPP e Diretoria de Planejamento Estratégico e Ações Intersetoriais, promovendo também articulações necessárias a esses temas em nível estratégico.

Secretaria Municipal de Administração Logística e Patrimonial (SMALOG): responsável pela gestão da prestação de serviços dedicados de comunicação.

Prodabel: dará suporte à SMSA em todos os temas relacionados aos investimentos em Tecnologia da Informação e equipamentos de informática, inclusive por meio da realização de especificação e análise técnica para ativos de tecnologia da informação para processos licitatórios dos mesmos, principalmente quanto à Legislação Nacional (pregão eletrônico e adesão a ata de registro de preços), obedecidos os limites e políticas de aquisições do BID.

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG): responsável pelos controles de contratações, serviços e uso de recursos do programa. A auditoria externa independente do programa poderá ser realizada, a critério da

SMSA, pelo próprio TCE MG mediante acordo de Cooperação Técnica.

Procuradoria Geral do Município (PGM): responsável por prestar assessoramento jurídico permanente ao Projeto, assegurando a legalidade, a segurança jurídica e a conformidade normativa dos procedimentos.

Controladoria-Geral do Município (CTGM): responsável pelo fortalecimento dos mecanismos de controle interno, integridade e transparência do Projeto.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Saúde
Órgãos parceiros:
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP)
Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA)
Procuradoria-Geral do Município (PGM)
Prodabel
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUPLOR)
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A capacidade institucional da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a implementação do Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde é considerada elevada, sendo respaldada pela experiência prévia em projetos de financiamento multilateral e pela alocação estratégica de competências.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), como Órgão Executor Principal, possui experiência comprovada na gestão de programas financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de ser pioneira na gestão bem-sucedida de Parcerias Público-Privadas (PPP) na área da saúde (PPP da APS), o que é um diferencial crucial para o componente de PPP de Edificações do presente projeto.

A execução das ações será centralizada na Unidade de Gestão de Projeto (UGP) da SMSA, que contará com uma equipe multidisciplinar composta por aproximadamente 20 profissionais, com formação em gestão de projetos, direito, economia, finanças, engenharia, monitoramento e aquisições, garantindo a aderência às políticas do BID. Essa capacidade gerencial é complementada pela expertise técnica da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), responsável pela coordenação, planejamento e supervisão das intervenções de infraestrutura previstas no Programa, assegurando a compatibilização dos projetos, o alinhamento institucional e a adequada integração das obras às necessidades assistenciais, bem como pela robusta atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), encarregada das obras de infraestrutura e do suporte técnico ao componente de PPP. Adicionalmente, a Prodabel garante o suporte especializado em Tecnologia da Informação, indispensável para a implementação dos componentes de Telessaúde e Sistemas de Gestão de Custos.

A estrutura combinada da PBH, portanto, demonstra competência técnica, experiência em modelos contratuais complexos (PPP) e um fluxo financeiro claro, minimizando os riscos de execução.

Do ponto de vista financeiro, a Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA) será responsável por receber os recursos provenientes dos desembolsos do contrato de empréstimo e transferi-los para a conta específica do Programa, vinculada à SMSA, bem como por disponibilizar os recursos de contrapartida do Tesouro Municipal, conforme o planejamento financeiro aprovado. Assim, haverá repasse formal de recursos da SMFA para a SMSA, garantindo fluxo financeiro claro, rastreável e compatível com as exigências do financiador.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade (RACI) ajustada após reunião com a Cofiex do dia 29.01.2026.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade dos resultados do Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte (Melhor Saúde BH II) está assegurada pela sua plena integração ao orçamento ordinário e à estrutura institucional da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

A operacionalização e manutenção do Programa após o período de execução do financiamento serão garantidas conforme a natureza dos componentes:

1. Sustentabilidade da Infraestrutura e Edificações (Componente Obras e PPP):

- Obras de Redes Especializadas (Execução SUDECAP): A responsabilidade pela manutenção predial e patrimonial das unidades de saúde reformadas e construídas diretamente com recursos do Programa será absorvida pela Gerência de Manutenção da SMSA (GEMAN), com recursos previstos no orçamento anual de custeio da pasta.

- Edificações da PPP: A sustentabilidade da infraestrutura construída ou reformada sob o regime de Parceria Público-Privada (PPP) é garantida pelo próprio contrato de concessão administrativa. O contrato de PPP estabelece a obrigação da Concessionária em manter a infraestrutura em plenas condições de uso e operação durante todo o prazo contratual. A contraprestação anual da Prefeitura, que é a fonte de pagamento da manutenção, será formalmente prevista e garantida na Lei Orçamentária Anual (LOA) da SMSA.

2. Sustentabilidade dos Sistemas de Informação e Telessaúde (Componente Modernização):

- Sistemas (Gestão de Custos e TI): os novos sistemas de informação e as ferramentas de gestão de custos serão incorporados à infraestrutura da Saúde e contarão com suporte técnico permanente da Prodabel. Os custos anuais de licenças de software, manutenção de hardware e infraestrutura de rede serão incluídos no Plano Plurianual (PPAG) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da SMSA, assegurando a continuidade operacional.

- Serviços de Telessaúde: o serviço de Telessaúde será institucionalizado como parte integrante da Rede de Atenção à Saúde de Belo Horizonte. Os custos de pessoal (teleconsultores, equipe de apoio) e a manutenção da plataforma tecnológica serão cobertos por dotação orçamentária regular da SMSA, que reconhece o Telessaúde como uma estratégia permanente de otimização de acesso e qualidade do cuidado.

3. Continuidade da Capacitação:

Os programas de capacitação iniciados durante a execução do Programa serão replicados no âmbito da Diretoria de Educação em Saúde, da SMSA. Isso garante que a atualização e o treinamento de novos profissionais no uso das ferramentas de Telessaúde, Sistemas de Custos e na manutenção da nova infraestrutura sejam processos contínuos e não dependam de recursos extraordinários do Programa.

A alocação da responsabilidade pela manutenção na SMSA e a garantia orçamentária da SMFA e do contrato de PPP conferem a segurança institucional necessária para a longevidade dos resultados do Programa.

3. 7. **Planejamento Estratégico**

O Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte (Melhor Saúde BH II) está alinhado aos principais instrumentos de planejamento do município: o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2026–2029), o Plano Municipal de Saúde (PMS 2026–2029) e o Planejamento Estratégico da Rede SUS-BH (PE 2026-2029).

O PPAG estabelece metas e prioridades estratégicas para um ciclo de quatro anos, orientando as ações governamentais com base em diagnósticos técnicos, estudos, evidências e demandas da população. Além de organizar programas e ações por áreas temáticas, o PPAG destaca projetos estruturantes e transformadores capazes de produzir impactos significativos no desenvolvimento de Belo Horizonte.

O PMS, por sua vez, é o instrumento central de planejamento do setor Saúde em cada esfera do SUS. Ele define compromissos e orienta a execução das políticas de saúde no período de quatro anos, a partir de uma análise situacional que considera necessidades da população, diretrizes nacionais e especificidades locais (Portaria de Consolidação GM/MS nº 1).

Os produtos resultantes do Planejamento Estratégico da SMSA-BH constituíram a base estratégica para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) e do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), instrumentos de planejamento obrigatórios da Administração Pública. Os objetivos determinados em sua construção estão refletidos de forma literal no PMS.

A seguir, apresenta-se a correspondência entre os Objetivos Específicos do Programa Melhor Saúde BH II e as referências equivalentes no PPAG e no PMS:

Objetivo Específico do Programa Melhor Saúde BH: 1. Fortalecer e expandir a Atenção Primária à Saúde, ampliando o acesso e a capacidade resolutiva		
Instru-mento	**Referência nos instrumentos**	**Objetivo do instrumento**
PPAG	Programa 0157: Atenção Primária à Saúde	Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como principal porta de entrada do SUS, com vistas à ampliação do acesso e à qualificação dos profissionais, da infraestrutura e dos processos de trabalho, com foco na integralidade do cuidado e na equidade no atendimento às necessidades de saúde da população.
	Programa 0310: Modernização da Atenção Primária na Saúde	Aprimorar a Atenção Primária à Saúde, por meio de iniciativas do Projeto Transformador, visando a reorganização dos serviços, incorporação de novas tecnologias e qualificação dos processos de trabalho para melhorar a atenção à saúde da população.
PMS	Objetivo: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1	Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde do SUS-BH
	Objetivo: 1.2	Fortalecer a Atenção Primária como ordenadora do cuidado e porta de entrada preferencial do SUS
	Objetivo: 3.2	Ampliar o cuidado em saúde mental e a atenção a populações vulneráveis

Objetivo Específico do Programa Melhor Saúde BH: 2. Consolidar a Rede Especializada e de Urgência, garantindo cuidado integral e qualificado		
Instru-mento	**Referência nos instrumentos**	**Objetivo do instrumento**

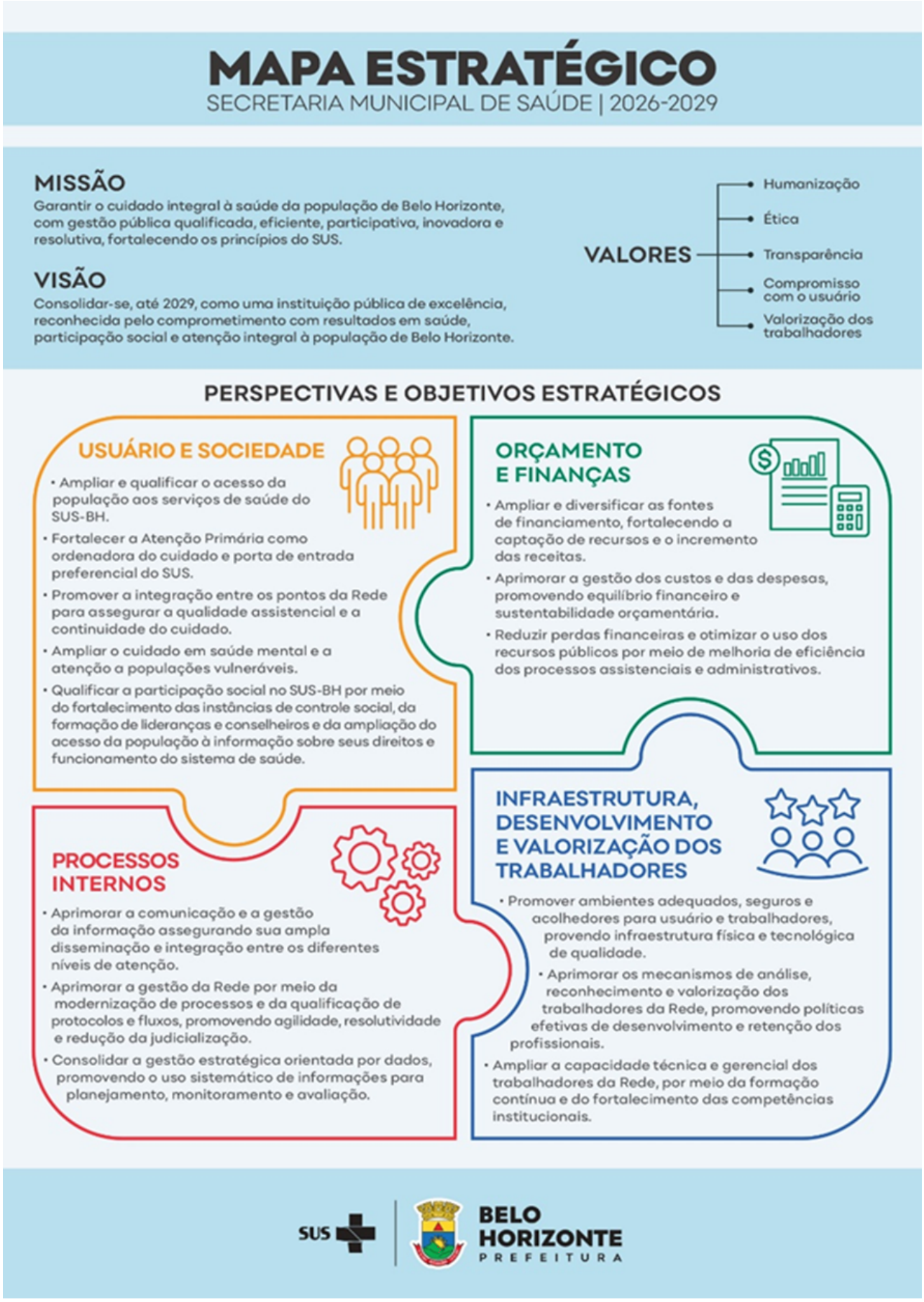
PPAG	Programa 0114: Atenção Especializada, Hospitalar e às Urgências e Emergências	Fortalecer a Atenção Primária à Saúde como principal porta de entrada do SUS, com vistas à ampliação do acesso e à qualificação dos profissionais, da infraestrutura e dos processos de trabalho, com foco na integralidade do cuidado e na equidade no atendimento às necessidades de saúde da população.
PMS	Objetivo: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1	Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde do SUS-BH
	Objetivo: 1.3, 2.2, 3.3	Promover a integração entre os pontos da Rede para assegurar a qualidade assistencial e a continuidade do cuidado
	Objetivo: 3.2	Ampliar o cuidado em saúde mental e a atenção a populações vulneráveis

Objetivo Específico do Programa Melhor Saúde BH: 3. Modernizar a gestão do sistema de saúde e incorporar tecnologias e modelos inovadores de cuidado		
Instru-mento	**Referência nos instrumentos**	**Objetivo do instrumento**
PPAG	Programa 0310: Modernização da Atenção Primária na Saúde	Aprimorar a Atenção Primária à Saúde, por meio de iniciativas do Projeto Transformador, visando a reorganização dos serviços, incorporação de novas tecnologias e qualificação dos processos de trabalho para melhorar a atenção à saúde da população.

PMS	Objetivo: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1	Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde do SUS-BH
	Objetivo: 1.3, 2.2, 3.3	Promover a integração entre os pontos da Rede para assegurar a qualidade assistencial e a continuidade do cuidado
	Objetivo: 1.4, 2.3, 3.4, 4.2	Promover ambientes adequados, seguros e acolhedores para usuário e trabalhadores, provendo infraestrutura física e tecnológica de qualidade
	Objetivo: 7.4	Consolidar a gestão estratégica orientada por dados, promovendo o uso sistemático de informações para planejamento, monitoramento e avaliação
	Objetivo: 7.6	Aprimorar a comunicação e a gestão da informação assegurando sua ampla disseminação e integração entre os diferentes níveis de atenção

Objetivo Específico do Programa Melhor Saúde BH: 4. Fortalecer a formação, o desenvolvimento profissional e a educação permanente em saúde		
Instru-mento	**Referência nos instrumentos**	**Objetivo do instrumento**
PPAG	Programa 0117: Gestão do SUS e Participação Social	Estruturar a gestão do SUS-BH por meio da modernização institucional, da qualificação dos serviços de apoio, do fortalecimento da força de trabalho, da participação social, do uso de tecnologias, da gestão de recursos e da adequação física e funcional da rede de unidades de saúde, incluindo sua ampliação e construção, visando à eficiência e à melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.
PMS	Objetivo: 5.1	Aprimorar os mecanismos de análise, reconhecimento e valorização dos trabalhadores da Rede, promovendo políticas efetivas de desenvolvimento e retenção dos profissionais
	Objetivo: 5.2	Ampliar a capacidade técnica e gerencial dos trabalhadores da Rede, por meio da formação contínua e do fortalecimento das competências institucionais

A partir do Mapa Estratégico da Rede SUS-BH é possível visualizar a reflexão dos seus objetivos no PMS.


MAPA ESTRATÉGICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2026-2029
MISSÃO
Garantir o cuidado integral à saúde da população de Belo Horizonte, com gestão pública qualificada, eficiente, participativa, inovadora e resolutiva, fortalecendo os princípios do SUS.
VISÃO
Consolidar-se, até 2029, como uma instituição pública de excelência, reconhecida pelo comprometimento com resultados em saúde, participação social e atenção integral à população de Belo Horizonte.
VALORES
Humanização
Ética
Transparência
Compromisso com o usuário
Valorização dos trabalhadores
PERSPECTIVAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
USUÁRIO E SOCIEDADE
• Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde do SUS-BH.
• Fortalecer a Atenção Primária como ordenadora do cuidado e porta de entrada preferencial do SUS.
• Promover a integração entre os pontos da Rede para assegurar a qualidade assistencial e a continuidade do cuidado.
• Ampliar o cuidado em saúde mental e a atenção a populações vulneráveis.
• Qualificar a participação social no SUS-BH por meio do fortalecimento das instâncias de controle social, da formação de lideranças e conselheiros e da ampliação do acesso da população à informação sobre seus direitos e funcionamento do sistema de saúde.
ORÇAMENTO E FINANÇAS
• Ampliar e diversificar as fontes de financiamento, fortalecendo a captação de recursos e o incremento das receitas.
• Aprimorar a gestão dos custos e das despesas, promovendo equilíbrio financeiro e sustentabilidade orçamentária.
• Reduzir perdas financeiras e otimizar o uso dos recursos públicos por meio de melhoria de eficiência dos processos assistenciais e administrativos.
PROCESSOS INTERNOS
• Aprimorar a comunicação e a gestão da informação assegurando sua ampla disseminação e integração entre os diferentes níveis de atenção.
• Aprimorar a gestão da Rede por meio da modernização de processos e da qualificação de protocolos e fluxos, promovendo agilidade, resolutividade e redução da judicialização.
• Consolidar a gestão estratégica orientada por dados, promovendo o uso sistemático de informações para planejamento, monitoramento e avaliação.
INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES
• Promover ambientes adequados, seguros e acolhedores para usuário e trabalhadores, provendo infraestrutura física e tecnológica de qualidade.
• Aprimorar os mecanismos de análise, reconhecimento e valorização dos trabalhadores da Rede, promovendo políticas efetivas de desenvolvimento e retenção dos profissionais.
• Ampliar a capacidade técnica e gerencial dos trabalhadores da Rede, por meio da formação contínua e do fortalecimento das competências institucionais.
SUS
BELO HORIZONTE
PREFEITURA

O alinhamento entre o Programa e os instrumentos oficiais de planejamento demonstra sua aderência às prioridades governamentais e reforça seu papel como iniciativa estruturante, com potencial de qualificar serviços, ampliar o acesso e promover inovações capazes de transformar a rede de saúde de Belo Horizonte.

3. 8. **Anexos**

Organograma

Mapa estratégico Secretaria Municipal de Saúde 2026-2029

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMS) 2026-2029.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2026-2029

Organograma ajustado após agenda com a Cofiex do dia 29/01/2026

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Atrasos na execução das obras (APS, Especializadas, Urgência, Vigilância, Logística)
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Risco de atrasos significativos no cronograma de construção, reforma ou ampliação das unidades previstas.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Fragilidade na elaboração dos projetos básicos e executivos, exigindo revisões técnicas e republicações.
- Questionamentos administrativos ou judiciais que comprometem a regularidade do processo licitatório.
- Baixa capacidade técnica ou financeira das construtoras contratadas.
- Condições climáticas, dificuldades e impedimentos operacionais.
- Dificuldades na articulação entre os diversos níveis e setores da administração pública municipal.
- Riscos externos relacionados a oscilações de mercado que afetam a precificação, a competitividade dos certames e a variação de preços de insumos.

Efeitos negativos:

- Prejuízo ao cronograma geral pactuado e a paralisação de obras ou processos de licitação.
- Aumento de custos diretos e indiretos com a necessidade de aditivos contratuais e perdas financeiras devido a rescisões.
- Dano à Imagem com a perda de credibilidade e desconfiança pública na capacidade da administração de gerir e concluir projetos.
- Comprometimento da qualidade com a entregas de infraestrutura ou serviços de qualidade inferior e desalinhamento com o escopo original do programa.

Prevenção e mitigação:

- Estudos de viabilidade detalhados e projetos executivos completos antes da licitação.
- Elaboração e revisão criteriosa dos projetos básicos e executivos com a inclusão de memoriais descritivos, cronogramas físicos e orçamentos de referência compatíveis com os preços de mercado antes da abertura dos certames.
- Alocação de equipe própria e exclusiva para condução dos processos licitatórios, com treinamento contínuo nas normas específicas e legislação atualizada, planejamento de compras públicas e gestão contratual
-

Gestão ativa de contratos, com indicadores de desempenho e penalidades.

- Monitoramento físico-financeiro mensal e visitas de supervisão de obras.
- Apoio da Controladoria Geral do Município (CTGM) nos processos de licitação e na execução da obra.
- Reforço contratual para cumprimento de prazos com inclusão de cláusulas contratuais específicas que prevejam penalidades por descumprimento de prazos, inadimplemento de metas físicas ou abandono de obras.
- Contratação de consultoria especializada para supervisionar as obras, com foco em conformidade técnica, ambiental e social, garantindo maior agilidade na resolução de entraves.

4. 20. **Informações do 2° risco:**
Nome: Atraso ou falhas na implementação das PPPs da APS
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de atraso na entrega das 20 unidades da APS via PPP ou problemas no modelo contratual e gestional.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Atrasos na fase de modelagem, aprovação ou assinatura de aditivo.
- Problemas de licenciamento ambiental/urbanístico.
- Dificuldade na obtenção do terreno.
- Condições climáticas adversas.
- Fiscalização municipal inadequada ou com baixa capacidade técnica.
- Aumento inesperado da contraprestação pela variação dos índices inflacionários.
- Falhas na governança ou no monitoramento da concessão.
- Falência ou baixo desempenho da Concessionária.

Efeitos negativos:

- Atraso no acesso da população aos serviços de saúde.
- Necessidade de prorrogação contratual.
- Unidades entregues fora do prazo estabelecido.
- Prejuízo ao atendimento da população e às metas do Programa.

- Aumento dos custos da contraprestação.
- Penalidades à Concessionária e possível intervenção/rescisão.

Prevenção e mitigação:

- Estabelecer metas intermediárias (marcos contratuais) com penalidades progressivas por atraso.
- Aperfeiçoamento da estrutura de gestão contratual.
- Avaliação rigorosa da capacidade técnica e financeira do proponente.
- Capacitação da equipe e manual de governança.
- Utilizar fórmulas de reajuste transparentes e índices oficiais (IPCA ou específicos para construção/saúde).
- Acompanhamento jurídico, financeiro e operacional contínuo.

4. 41. **Informações do 3° risco:**
Nome: Insuficiência de capacidade institucional para gestão e fiscalização da PPP
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A unidade Gestora da PPP pode apresentar limitações quanto à expertise ou dimensionamento de equipe para monitorar, fiscalizar e aplicar as penalidades de forma eficaz, comprometendo a qualidade e a regularidade dos serviços entregues no âmbito da parceria.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Rotatividade e subdimensionamento de equipes.
- Falta de especialização técnica em PPPs e contratos de desempenho.
- Processos internos pouco estruturados.
- Mudança de gestão política (descontinuidade da equipe).
- Inexistência de regras claras de comunicação e tomada de decisão.
- Falta de padronização nos processos de gestão de contratos.

Efeitos negativos:

- Riscos de mau desempenho do parceiro privado.

- Incapacidade de medir o desempenho da Concessionária
- Pagamento inadequado de contraprestações.
- Fragilização da governança da PPP.
- Disputas contratuais frequentes.
- Deterioração da qualidade dos serviços das unidades APS por falta de cobrança e monitoramento adequado. .

Prevenção e mitigação:

- Garantir a Capacitação para a certificação internacional em PPPs, como obrigatória para a equipe de gestão.
- Criar uma Unidade de Gestão de PPPs dedicada e multissetorial.
- Contratar Acompanhamento Jurídico, Econômico e Operacional para apoio técnico contínuo.
- Implantação do Manual de Governança
- Uso de monitoramento permanente

4. 59. **Informações do 4° risco:**
Nome: Atraso/Fracasso nas aquisições, contratações e entrega de Bens, Serviços e equipamentos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os processos de aquisição podem atrasar ou fracassar devido à complexidade das especificações, à necessidade de adequação às normas complementares, à baixa oferta de fornecedores e aos entraves administrativos da administração pública nas etapas de licitação, comprometendo a entrega dos equipamentos essenciais ao funcionamento das unidades.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Especificações técnicas muito restritivas e inadequadas.
- Problemas de cadeia de suprimentos global
- Problemas de fornecimento nacional e internacional.
- dificuldades de licitar equipamentos de alto valor/tecnologia

Efeitos negativos:

- Atraso crítico na entrada em funcionamento das unidades que estarão fisicamente prontas, mas inoperantes.
-

Custo de manutenção, segurança e conservação de um prédio ocioso, sem gerar benefício

- Reprogramação de obras e instalações para equipamentos de grande porte.
- Perdas de garantia e obsolescência dos equipamentos.

Prevenção e mitigação:

- Planejamento integrado entre a conclusão das obras e a data de entrega dos equipamentos.
- Estudos de mercado detalhados para garantir a concorrência.
- Incluir no contrato penalidades progressivas e claras por atraso na entrega.
- Garantir a gestão logística ativa e rastreabilidade na entrega.

4. 72. **Informações do 5° risco:**
Nome: Falhas na implantação dos sistemas digitais (Telessaúde, modelos preditivos, gestão de filas, zoonoses, centro de custos)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A implantação dos sistemas digitais pode enfrentar falhas técnicas e de integração, atrasos na entrega e incompatibilidade com a infraestrutura existente. Isso compromete a operacionalização das funcionalidades previstas, reduzindo a efetividade das entregas do programa e afetando diretamente a qualidade da gestão e dos serviços prestados à população.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Complexidade técnica.
- Baixa maturidade dos processos internos.
- Integração inadequada entre sistemas legados e novas soluções.
- Documentação incompleta dos sistemas legados
- Fornecedores com capacidade limitada.
- Ausência de padrões de interoperabilidade.
- Insuficiência de capacitação das equipes
- Resistência à adoção das novas ferramentas.

Efeitos negativos:

- Sistemas subutilizados e desperdício de recursos financeiros.
-

Interrupção ou atraso na oferta de serviços digitais com prejuízo do acesso aos usuários.

- Baixa eficiência dos serviços modernizados.
- Aumento do retrabalho pela necessidade de manter processos manuais paralelos.
- Atrasos na integração entre unidades e áreas, afetando o monitoramento, auditorias e gestão de filas.
- Risco de paralisações operacionais, caso falhas causem indisponibilidade de sistemas críticos.
- Perda de investimentos. Inviabilidade da Modelagem Preditiva e Gestão de Filas

Prevenção e mitigação:

- Planejamento modular com entregas contínuas.
- Arquitetura de interoperabilidade definida antecipadamente para garantir integração com sistemas legados.
- Contratos com indicadores e testes de qualidade.
- Definir requisitos técnicos claros e completos no processo de contratação de sistemas e fornecedores.
- Acompanhar a implantação por meio de comitê técnico especializado, garantindo monitoramento constante e correção rápida de falhas.
- Oferecer capacitação contínua às equipes técnicas e assistenciais.

4. 94. **Informações do 6° risco:**
Nome: Riscos socioambientais e de segurança nas obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de impactos ambientais adversos, acidentes de trabalho, falhas de segurança operacional ou efeitos negativos sobre a comunidade do entorno durante a execução das obras e deterioração das relações institucionais.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Planejamento ambiental insuficiente, sem adequada avaliação dos impactos das obras.
- Gestão inadequada de resíduos (entulho, substâncias químicas, efluentes).
- Não conformidade com normas de segurança do trabalho (NRs).
- Adoção de técnicas construtivas inadequadas, gerando maiores impactos ambientais.
- Conflitos com moradores ou comerciantes locais, devido a ruído, poeira ou bloqueio de vias.

- Monitoramento insuficiente dos aspectos socioambientais e de segurança por parte da contratada ou da supervisão.

Efeitos negativos:

- Interrupção das obras, por embargos ambientais, fiscais ou trabalhistas.
- Aumento dos custos, decorrente de retrabalho, multas, indenizações ou adequações emergenciais.
- Atrasos no cronograma, comprometendo metas e entregas previstas.
- Judicialização, devido a acidentes ou danos ambientais atribuídos ao empreendimento.

Prevenção e mitigação:

- Elaboração e implementação de Plano de Gestão Socioambiental (PGSA) específico para as obras.
- Avaliação prévia de riscos ambientais, incluindo ruído, vibração, poeira e supressão vegetal.
- Garantia de cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança do trabalho.
- Auditorias regulares de segurança e meio ambiente, realizadas pela supervisão ou equipe técnica do projeto.
- Plano de comunicação social, garantindo informação adequada à comunidade do entorno.
- Incorporação de critérios socioambientais nos contratos.

4. 111. **Informações do 7° risco:**
Nome: Riscos associados à desapropriação ou obtenção de terrenos e imóveis
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atrasos, impedimentos legais, custos adicionais ou inviabilização parcial das ações do projeto em razão de dificuldades na desapropriação, aquisição, cessão ou regularização fundiária de terrenos e imóveis necessários à implementação do Programa.

Prevenção e Mitigação:
Possíveis causas:

- Situação fundiária irregular ou indefinida dos terrenos selecionados.
- Demora nos processos administrativos de desapropriação ou aquisição de imóveis.
- Contestações judiciais por parte de proprietários ou terceiros.
- Resistência social ou conflitos com ocupantes formais ou informais das áreas.
- Falta de articulação entre áreas técnicas, jurídicas e patrimoniais do ente executor.

- Exigências adicionais de órgãos de controle ou do Poder Judiciário.

Efeitos negativos:

- Atrasos significativos no início ou na continuidade das obras, afetando o cronograma do Programa
- Necessidade de reprogramação ou alteração de escopo, com substituição de terrenos ou unidades.
- Elevação dos custos do projeto, devido a indenizações, encargos legais ou soluções alternativas.
- Judicialização prolongada, com paralisação de frentes de obra.
- Risco de descumprimento de prazos contratuais e metas pactuadas com o BID/COFIEX.

Prevenção e mitigação:

- Mapeamento e análise fundiária prévia de todos os terrenos necessários ao projeto.
- Priorização de áreas públicas ou já regularizadas, sempre que possível.
- Avaliações imobiliárias técnicas e atualizadas, garantindo maior segurança jurídica.
- Previsão orçamentária adequada para indenizações e eventuais reassentamentos.
- revisão e substituição de terrenos, quando viável, para evitar paralisações prolongadas.
- Atuação jurídica intensiva e coordenada, para acelerar processos judiciais ou administrativos.
- Negociação direta com proprietários e comunidades, com mediação institucional.

4. 130. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Real	0.1857	626.880.000,00	145.514.520,00	783.600.000,00	156.720.000,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	222	246

Juros aplicáveis:
14,15% (CDI) - 0,13% (spread VMP 15 anos) +0,8% (capital ordinário) = 14,82% ao ano. Tabela de VMP (data base 03/2025)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0.

Outras Informações:

Os juros aplicáveis constituem-se do CDI, subtraído do spread da VMP de 15 anos no momento de cada desembolso, adicionado da margem de capital ordinário de 0,8% ao ano em 2025. Assim, os juros aplicáveis nesta operação são: 14,15% (CDI) - 0,13% (spread VMP 15 anos) +0,8% (capital ordinário) = 14,82% ao ano.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 1 - Ampliação e fortalecimento da rede de atenção à saúde SUS-BH por meio da Parceria Público Privada					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
17.634.000,00	78.345.000,00	54.810.000,00	78.375.000,00	87.107.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
77.197.000,00	0,00	81.327.000,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 2 - Ampliação e consolidação dos serviços especializados e de urgência e emergência					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	94.200.000,00	0,00	94.446.800,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
20.837.440,00	0,00	12.632.760,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 3 - Modernização, ampliação e qualificação do cuidado e gestão em saúde					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
200.000,00	0,00	16.980.100,00	0,00	25.720.900,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 4 - Gestão do Programa					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.457.400,00	0,00	8.093.200,00	0,00	7.773.200,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
5.281.600,00	0,00	5.781.600,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

1. receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;

2. recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e

3. recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA-BH), vem desenvolvendo ações contínuas voltadas ao fortalecimento, ampliação e modernização dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH).

No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS-BH), desde 2016 a SMSA-BH mantém contrato de concessão, em regime de Parceria Público-Privada (PPP), destinado à entrega de obras e serviços de apoio à operação da rede. Conforme o Relatório Anual de Gestão de 2024, cinco novos Centros de Saúde foram entregues à população naquele ano, e, até dezembro de 2025, outros quatro também foram concluídos, compondo a rede de 153 Unidades Básicas de Saúde.

Com o Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte – Melhor Saúde BH, firmado em 2019 junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, foram entregues sete Centros de Saúde sob regime de PPP, como contrapartida adicional, nos anos de 2023 e 2024, reforçando as melhorias na APS-BH.

O contrato de concessão, com execução iniciada em 2019, prevê a construção e reconstrução de Centros de Saúde, priorizando áreas de maior vulnerabilidade social associadas à viabilidade técnica das obras. Os novos Centros de Saúde são entregues completamente equipados com mobiliário e equipamentos clínicos necessários ao funcionamento da APS-BH, incluindo estrutura para ampliação das Equipes de Saúde da Família e espaços adequados para equipes de Saúde Bucal, Saúde Mental, Multiprofissionais, entre outras.

Em 17/02/2025, foi firmado com a concessionária o 15º Termo Aditivo ao contrato de concessão, prevendo a ampliação das unidades a serem reconstruídas e elevando o escopo para 69 unidades, contribuindo para o fortalecimento de serviços que já vêm recebendo investimentos da Prefeitura de Belo Horizonte. Para além da continuidade de 7 unidades desse aditivo, existe o interesse em expandir ainda mais o escopo contratual, oportunidade na qual o financiamento pretendido seria fundamental.

Já nos serviços especializados e de urgência e emergência, a SMSA-BH executa, por meio do Programa Melhor Saúde BH, obras de reforma, adequação e ampliação de unidades de urgência e emergência. Três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão atualmente em obra em diferentes regionais da capital. Para a rede especializada, uma nova unidade de referência de saúde mental também teve suas obras iniciadas no âmbito do programa.

Além das intervenções estruturais, as unidades foram equipadas com novos equipamentos clínicos, mobiliários médicos e tecnologias assistenciais, elevando a qualidade dos exames, dos serviços de diagnóstico por imagem e, consequentemente, do atendimento prestado à população.

Outros esforços de investimentos da SMSA-BH incluem a reforma e ampliação de um serviço especializado em saúde bucal, a reforma da maternidade do Hospital Metropolitano Odilon Behrens e a construção de um complexo de saúde destinado à rede especializada, com serviços como Centro Municipal de Oftalmologia, Centro de Reabilitação e Unidade de Referência Secundária, entre outros, reforçando o compromisso da SMSA-BH com a consolidação e ampliação dos serviços oferecidos à população usuária do SUS-BH

No campo da modernização, destaca-se a principal entrega de 2024: a implantação da Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e Regulação em 346 unidades de saúde da rede SUS-BH. Essa solução criou o prontuário eletrônico único do cidadão e integrou digitalmente toda a rede, qualificando o atendimento e centralizando informações essenciais. Trata-se de um dos maiores projetos de tecnologia em saúde já executados pela SMSA-BH.

A implantação do prontuário eletrônico único em todos os pontos ambulatoriais, hospitalares e de urgência permite que informações de cada atendimento sejam acessadas em qualquer serviço da rede. Essa integração amplia a segurança do paciente, otimiza a gestão de dados e fortalece a produção de indicadores para apoiar o planejamento e a tomada de decisão em saúde.

O Relatório Anual de Gestão de 2024 também destaca a implementação de estratégias de teleconsulta, especialmente para Síndromes Gripais, permitindo atendimento contínuo para pacientes com agravos sem risco à vida e elegíveis ao teleatendimento.

Com esses avanços estruturais, tecnológicos e assistenciais, o Município de Belo Horizonte reafirma os investimentos já realizados para qualificar a oferta dos serviços de saúde do SUS-BH, com ações executadas ou em estágio avançado de implantação e entregas de grande relevância para a população.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download